

الدعم الاجتماعي وعلاقته ببعض الاضطرابات النفسية لدى العاملين بالمستشفيات.

صلاح مستور عايض الثبتي

باحث الماجستير في كلية الآداب-جامعة الفيوم

تخصص علم النفس الإكلينيكي

د.هناء كارم توفيق

مدرس علم النفس الإكلينيكي
كلية الآداب – جامعة الفيوم

أ.م.د/ محمد فتحي سليمان

أستاذ مساعد علم النفس الإكلينيكي
كلية الآداب – جامعة الفيوم

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الدعم الاجتماعي وعلاقته ببعض الاضطرابات النفسية لدى العاملين بالمستشفيات. تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 168 موظفًا في مستشفى النور بمكة المكرمة من القطاعين الطبي والإداري، حيث شكل الذكور النسبة الأكبر (٥٧.١%)، وكانت الفئة العمرية الأقل من ٣٠ سنة هي الأكثر مشاركة، وأغلب على العينة من العاملين في القطاع الطبي.

أظهرت نتائج تحليل الفرضيات وجود علاقة سلبية دالة إحصائيًا بين الدعم الاجتماعي والقلق (-0.٥٢٣) وبين الدعم الاجتماعي والاكتئاب (-0.493)، مما يدل على أن زيادة الدعم الاجتماعي تقلل من مستويات القلق والاكتئاب. أما الفرضية المتعلقة بتأثير المتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، الوظيفة، سنوات الخبرة) فقد تم رفضها، حيث لم تؤثر هذه المتغيرات على مستويات الدعم الاجتماعي أو القلق أو الاكتئاب.

خلصت الدراسة إلى أن الدعم الاجتماعي يعد عاملاً وقائيًا مهمًا لتقليل القلق والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز برامج الدعم الاجتماعي وورش العمل للمهارات النفسية، ودمج الصحة النفسية ضمن سياسات الموارد البشرية، مع تقييم مستمر لفعالية هذه البرامج.

الكلمات المفتاحية: الدعم الاجتماعي، القلق، الاكتئاب، العاملون بالمستشفيات، الاضطرابات النفسية.

المقدمة:

يُعدّ العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، لذا من الضروري أن تسعى المؤسسات إلى تبني أسلوب إداري قائم على الإصغاء للعاملين وفهم مشاعرهم واحتياجاتهم، مع العمل على توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة، كما ينبغي تحقيق التوافق بين الأهداف الشخصية للعاملين والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بما يعزز شعورهم بالانتماء والولاء التنظيمي، ويدفعهم لبذل أقصى جهودهم في سبيل تحقيق النجاح الفردي والمؤسسي على حدّ سواء (طه، ٢٠٢١).

أصبح القلق جزءًا لا يتجزأ من بيئات العمل الحديثة، ويؤثر على الموظفين في مختلف القطاعات والأدوار الوظيفية، وقد ساهمت طبيعة أماكن العمل المتطلبة اليوم، إلى جانب الضغوط الخارجية المتنوعة، في انتشار التوتر بين العاملين، ونتيجةً لذلك، أصبح فهم تأثير التوتر على أداء الموظفين ورضاهم الوظيفي أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات التي تسعى إلى الحفاظ على قوة عاملة منتجة ومحفزة (Avr & Srinivasa, 2024).

يُعدّ الاكتئاب من أبرز المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر سلبيًا في بيئة العمل، إذ يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على أداء الأفراد ومستوى إنتاجيتهم. وتُعدّ أقسام الطوارئ بيئة عمل تتسم بالضغط الشديد والتحديات المستمرة، مما يجعلها أكثر عرضة لظهور مثل هذه الاضطرابات النفسية. لذا فإن فهم العلاقة بين سمات الشخصية والاكتئاب يُسهم في تحسين بيئة العمل، ويساعد على وضع استراتيجيات فعّالة لدعم العاملين والحد من تأثير الضغوط النفسية في أدائهم المهني (Lerner, et al., 2010).

يُعدّ الدعم الاجتماعي حاجة أساسية لكل فرد في حياته اليومية، إذ لا يقتصر على كونه مصدرًا للمساندة، بل يمثل ضرورة ملحة تزداد أهميتها كلما واجه الفرد مواقف حياتية صعبة أو ضغوطًا نفسية، حيث أن وجود الدعم الاجتماعي يُسهم في مساعدة الفرد على تقييم الضغوط التي يمر بها بطريقة واقعية وأكثر اتزانًا، مما يُعينه على التعامل معها بفعالية أكبر، كما يؤثر مستوى الدعم الاجتماعي المتاح على إدراك الفرد لطبيعة الضغوط وكيفية مواجهتها، ويُسهم في تلبية حاجاته النفسية والاجتماعية، إضافةً

إلى ذلك، يلعب الدعم الاجتماعي دورًا مهمًا في تعزيز الشعور بالأمن النفسي وخفض حدة المعاناة النفسية الناتجة عن التحديات والضغوط المختلفة (علي، ٢٠٠٥).

يُعدّ مجال الصحة من أكثر المجالات التي يتعرض فيها العاملون لمستويات مرتفعة من الضغوط والتوترات النفسية، مما يترك آثارًا واضحة على جوانبهم النفسية والاجتماعية، فكثيرًا ما يواجه العاملون في القطاع الصحي مواقف وظروفًا معقدة تتسم باضطرابات نفسية من القلق و الاكتئاب وهو ما ينعكس سلبيًا على صحتهم النفسية ومستوى أدائهم المهني،

ويُلاحظ أن الأطباء والممرضين على وجه الخصوص يتحملون مسؤوليات كبيرة داخل المنظومة الصحية، إذ يمثلون عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية العلاجية وتحقيق جودة الرعاية المقدمة للمرض (غانم و كافي، ٢٠٢٤).

يسعى الباحث في الدراسة الحالية ببحث علاقة الدعم الاجتماعي ببعض الاضطرابات النفسية لدى العاملين بالمستشفيات.

- مشكلة الدراسة:

يحظى قطاع الصحة والعاملون فيه بأهمية كبيرة نظرًا لما يقدمه من خدمات أساسية تمس حياة الأفراد والمجتمع، إلا أن العاملين في المستشفيات يُعدّون من أكثر الفئات تعرضًا للضغوط المهنية والنفسية نتيجة لطبيعة عملهم التي تتطلب دقة عالية وسرعة في اتخاذ القرار ومواجهة مستمرة لحالات إنسانية صعبة، مما يجعلهم أكثر عرضة لاضطرابات القلق والاكتئاب (Alnazly, et al., 2021).

يُعدّ الدعم الاجتماعي ذا دورٍ جوهريٍّ في الحد من الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب، إذ يعمل كحاجز نفسي واقٍ يساعد الفرد على التكيف مع بيئة العمل الضاغطة ويحافظ على استقراره الانفعالي والاجتماعي (Katsiroumpa, et al, 2025). أشارت دراسة (Alalawi et al., 2023) التي جاء تطبيقها بقسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى ٥٧٣٥٧ أن ٦٦ % من العاملين في الرعاية الصحية عانوا من الاكتئاب والقلق خلال فترة الوباء الدراسة تهدف للمساهمة في وضع خطط استباقية لمواجهة الأزمات وتُوصى بالدعم النفسي واتخاذ إجراءات لتخفيف الضغوط عن العاملين

بالصحة خلال فترات الوباء. وأكدت نتائج الدراسة أن ٦٦% من العاملين بمجال الرعاية الصحية، كانت لديهم درجات مختلفة من القلق والاكتئاب خلال فترة الوباء، و أظهرت الدراسة أن الممرضات تمثل أعلى مستويات القلق. وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ مؤسسات الرعاية الصحية إجراءات عديدة لتقليل العبء النفسي عن العاملين في الرعاية الصحية، كما أكدت على أهمية تلقيهم دعمًا نفسيًا قويًا خلال فترات الأوبئة، وهو ما يجب مراعاته استعدادًا لأي وباء آخر.

و أوضحت دراسة (Sarason و آخرون) أن الأفراد الذين لا يُقدّم لهم دعم يعانون من القلق والتشاؤم تجاه الحاضر والمستقبل (Sarason et al.,1983).

أكدت دراسة (Dvork,1988) أن الأفراد يميلون إلى الوحدة النفسية عندما يشعرون بعدم توفير الدعم الاجتماعي لهم حيث إن إدراك الفرد لعدم وجود دعم اجتماعي سيشعره بعدم القدرة على المواجهة وتكون هنا بداية انخفاض مستوى الصحة النفسية لديه.

يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في الاضطرابات التي يتعرض إليها العاملين في المستشفيات، وتحديد دور الدعم الاجتماعي ودوره في تخفيف تلك الاضطرابات ويمكن تحديد المشكلة في التساؤلات الآتية:

١. ما مستوى الدعم الاجتماعي والاضطرابات النفسية لدى العاملين بالمستشفيات؟
٢. هل توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بالمستشفيات؟
٣. هل توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات؟
٤. هل يوجد تباين في كل من متوسطات الدعم الاجتماعي و القلق و الاكتئاب باختلاف (الجنس، العمر، الوظيفة، سنوات الخبرة)؟

- أهداف الدراسة:

١. التعرف على طبيعة العلاقة بين الدعم الاجتماعي ومستوى القلق لدى العاملين في المستشفيات.
٢. الكشف عن العلاقة بين الدعم الاجتماعي ومستوى الاكتئاب لدى العاملين في المستشفيات.

٣. تحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب باختلاف) الجنس، العمر، طبيعة الوظيفة، سنوات الخبرة (لدى العاملين في المستشفيات.

٤. تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي يمكن أن تساعد إدارات المستشفيات في تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي الرسمية وغير الرسمية بين العاملين، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتقليل معدلات القلق والاكتئاب.

- أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:

أولاً - الأهمية النظرية:

تتمثل الأهمية النظرية للدراسة الحالي تقديم أطر نظرية و إثراء الأدبيات حول مفاهيم هامة تتعلق بالدعم الاجتماعي لدى العاملين بالمستشفيات، والاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب لدى العاملين في المستشفيات.

ويعمل الباحث على سد الفجوة البحثية للدراسات السابقة من خلال تناولها الفئات العاملة في المجال الصحي، وهي فئة تتعرض لضغوط عالية ومستمرة، مما يجعل نتائجها ذات قيمة علمية يمكن البناء عليها في بحوث لاحقة تهدف إلى تطوير نماذج نظرية أكثر شمولاً حول دور الدعم الاجتماعي في تحسين الصحة النفسية في بيئات العمل المجهدة.

ثانياً - الأهمية التطبيقية:

تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في إمكانية الاستفادة من نتائجها في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي بين العاملين، سواء على مستوى الزملاء أو الإدارة. كما تُسهم في توجيه صانعي القرار في القطاع الصحي إلى تبني سياسات عملية تهدف إلى خفض مستويات القلق والاكتئاب عبر بناء بيئة تنظيمية قائمة على التعاون والتقدير المتبادل.

كما أن نتائج الدراسة قد تُساعد في تصميم برامج تدريبية وإرشادية تهدف إلى رفع الوعي النفسي والاجتماعي لدى العاملين في المستشفيات، وتزويدهم بمهارات مواجهة ضغوط العمل بطرق صحية وإيجابية.

كذلك تُعد الدراسة ذات قيمة تطبيقية للمؤسسات الصحية في تقييم فعالية أنظمة الدعم الحالية وتطوير استراتيجيات جديدة تعزز من رضا العاملين وولائهم للمؤسسة وتحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة.

- مصطلحات الدراسة:

١. الدعم الاجتماعي (Social Support):

يُعرف الدعم الاجتماعي بأنه توافر موارد نفسية ومادية يحصل عليها الفرد من خلال علاقاته الاجتماعية، وتتميز هذه العلاقات بكونها مستمرة ويمكن الوثوق بها والاعتماد عليها في الأوقات التي يشعر فيها الفرد بالحاجة إلى المساندة، حيث تزوده بالدعم العاطفي والمعنوي الذي يساعده على مواجهة المواقف الصعبة والتكيف معها . (L.Zhang,et al.,2023)

- التعريف الإجرائي للدعم الاجتماعي: هي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الدعم الاجتماعي. و يُقصد به الدرجة التي يشعر بها العاملون في المستشفيات بتلقي الدعم الاجتماعي من زملائهم ورؤسائهم في العمل.

يُقاس هذا المتغير من خلال استجابات أفراد العينة على فقرات مقياس الدعم الاجتماعي المستخدم في الاستبانة، حيث تعكس الدرجات المرتفعة مستوىً عاليًا من الدعم الاجتماعي المدرك، بينما تشير الدرجات المنخفضة إلى ضعف هذا الدعم.

٢. القلق (Anxiety):

هو حالة شعورية عامة تتسم بالإحساس بالخوف والقلق والتوجس دون وجود سبب واضح أو محدد، وغالبًا ما ترافقها أعراض جسدية متكررة مثل ضيق التنفس، وتسارع ضربات القلب، والشعور بالانقباض في الصدر أو التوتر المستمر (Alkabaa,et al.,2025).

- التعريف الإجرائي للقلق: هي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس القلق.

و يُقصد به الدرجة التي يعبر بها العاملون في المستشفيات عن شعورهم بالتوتر الدائم، أو الخوف من الفشل، أو القلق من المستقبل المهني والشخصي، نتيجة لضغوط العمل

المستمرة أو الظروف المحيطة ببيئة العمل، ويُقاس هذا المتغير من خلال استجابات المبحوثين على فقرات مقياس القلق المدرج في الاستبانة، حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى مستوى عالٍ من القلق، بينما تعكس الدرجات المنخفضة إحساساً أقل بالتوتر والاضطراب النفسي.

٣. الاكتئاب (Depression):

هي حالة انفعالية تتميز بشعور مستمر بالحزن تتدرج من حزن معتدل أو شعور بالوجوم إلى أقصى درجات اليأس والقنوط، وغالباً ما ترافقها مجموعة من الأعراض مثل فقدان الدافعية، وضعف النشاط، والأرق، وفقدان الشهية، وصعوبة التركيز، والعجز عن اتخاذ القرارات، مما يؤثر سلباً في الأداء اليومي للفرد وحياته النفسية والاجتماعية (جابر عبد الحميد وعلاء كفاي، ١٩٩٠).

- **التعريف الإجرائي للاكتئاب:** هي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الاكتئاب.

و يُقصد بالاكتئاب به الدرجة التي يظهر بها العاملون في المستشفيات مشاعر الحزن وفقدان الدافعية وضعف الشعور بالإنجاز، نتيجةً لضغوط مهنية أو نفسية متراكمة في بيئة العمل، ويُقاس هذا المتغير من خلال استجابات أفراد العينة على فقرات مقياس الاكتئاب المستخدم في الاستبانة، بحيث تشير الدرجات المرتفعة إلى مستوى عالٍ من الاكتئاب النفسي، بينما تعكس الدرجات المنخفضة حالة نفسية مستقرة وخالية من الأعراض الاكتئابية.

الإطار النظري للدراسة:

أولاً الدعم الاجتماعي:

مفهوم الدعم الاجتماعي:

يعرف الدعم الاجتماعي لغةً و اصطلاحاً من خلال العديد من الأدباء والعلماء على النحو التالي:

الدعم الاجتماعي لغةً:

مشقة من الفعل (دَعَمَ) دعم الشيء يدعمه دَعْمًا: مال فأقامه، و الدعمة: ما دعمه به، و الدعام و الدعامة: كالدعامة و الدعم: أن يميل الشيء فتدعمه بدعام كما تدعم عروش الكرم و نحوه (ابن منظور، ١٩٩٣).

يُعرّف الاجتماعي في اللغة في اللغة مأخوذة من الفعل اجتمع، ويُقال: اجتمع القومُ أي تَأَلَّفُوا وتَقَارَبُوا وتعاونوا على أمرٍ واحد. (ابن منظور، ١٩٩٣).

الدعم الاجتماعي اصطلاحاً: يُعدّ الدعم الاجتماعي من المتغيرات التي تتوّعت تعريفاته تبعاً لاختلاف التوجهات النظرية للباحثين. فمن المنظور السوسيولوجي، يُنظر إليه على أنه يرتبط بعدد ونوعية العلاقات الاجتماعية التي تربط الفرد بغيره داخل بيئته الاجتماعية، أي بدرجة تكامله الاجتماعي ومدى اندماجه في شبكة من العلاقات الداعمة. ويُعتقد أن هذا التكامل الاجتماعي يسهم في تعزيز مستوى الصحة العامة للفرد وتحسين قدرته على التكيف مع الضغوط الحياتية (Bunk & Hooens, 1992).

إن الأساس النظري الذي ينطلق منه اصطلاح الدعم الاجتماعي، فإنه يبدو من خلال: هذا المفهوم أنه يشمل على مكونين رئيسيين:

-**المفهوم الأول:** إدراك الفرد لوجود عدد كافٍ من الأشخاص في حياته يمكنه الاعتماد عليهم واللجوء إليهم عند الحاجة.

-**المفهوم الثاني:** يشير إلى مدى رضا الفرد عن الدعم المتاح له ومدى اقتناعه بكفايته وقدرته على تلبية احتياجاته النفسية والاجتماعية (Cutrona & Russel, 1990).

يتمثل الدعم الاجتماعي في علاقات إيجابية يسودها الحب والود والثقة والتقدير، وتُعد هذه العلاقات بمثابة دروع واقية أو حواجز نفسية تحمي الفرد من آثار الضغوط المختلفة (محمد، ٢٠١١).

يُعدّ الدعم الاجتماعي هو أساليب المساعدة المختلفة التي يتلقاها الفرد من أسرته وأصدقائه، والتي تتمثل في تقديم الرعاية والاهتمام والتوجيه والنصح والتشجيع في كافة مواقف الحياة، والتي تشبع حاجاته المادية والروحية للقبول والحب والشعور بالأمان فتجعله يثق بنفسه ويدركها الفرد، مما يزيد من كفاءته الاجتماعية (حنفي، ٢٠٠٧).

أنواع الدعم الاجتماعي:

وقد قسم الباحثون الدعم الاجتماعي إلى:

١ - الدعم الاجتماعي الوجداني:

إظهار لمشاعر الثقة والمودة والحنان تجاه الآخرين، كما يُنظر إليه على أنه سند نفسي ومعنوي يجده الفرد في وقوف الناس إلى جانبه، ومشاركتهم له أفراحه وأحزانه، وتعاطفهم معه واهتمامهم بشؤونه. ويسهم هذا الدعم في تعزيز شعور الفرد بالثقة بنفسه وبالأخرين، مما يجعله أكثر قدرة على التمتع بالسراء بصدر رحب، والتحلي بالصبر والثبات في مواجهة الضراء(مرسي، ٢٠٠٠).

٢ - الدعم المعنوي (المدرّك):

يُعرّف بأنه ذلك الدعم النفسي الذي يتلقاه الفرد من خلال كلمات التهنئة والثناء في أوقات السعادة، ومن خلال ما يلقاه من تقدير واستحسان وتقبّل ومشاعر حب متبادلة من الآخرين. كما يتمثل في عبارات المواساة والتعاطف التي تُقدّم له في أوقات الشدة، مما يُسهم في التخفيف من مشاعر التوتر والقلق والضيق، ويُشجّعه على النظر إلى ما يمرّ به من مواقف بنظرة إيجابية وتفاؤلية(قنون، ٢٠٠٧).

٣ - الدعم السلوكي:

يُشير هذا النوع من الدعم إلى تقديم المساندة العملية من خلال المشاركة في أداء المهام والأعمال المختلفة، وبذل الجهد البدني لمساعدة الفرد على إنجاز ما يقوم به من مسؤوليات، مما يُخفف من الأعباء الواقعة عليه ويُعزز شعوره بالتعاون والانتماء(رضوان، ٢٠٠١).

٤ - الدعم المادي:

يتمثل هذا النوع من الدعم في تقديم المساعدة أو العون المادي للفرد عند حاجته، سواء في صورة أموال أو موارد أو خدمات مادية، بما يُسهم في تلبية احتياجاته الأساسية، ويُخفف من الضغوط الاقتصادية التي قد يواجهها، مما ينعكس إيجاباً على استقراره النفسي والاجتماعي(يخلف، ٢٠٠١).

٥- الدعم المعلوماتي:

يشمل هذا النوع من الدعم تقديم المعلومات والآراء والنصائح والتوجيهات التي تساعد الفرد على فهم عوامل النجاح أو أسباب الفشل بشكل أعمق، مما يعزز قدرته على الاستمرار في تحقيق النجاح والتعامل بمرونة مع الإحباطات، كما أن تلك النصائح قد تمكنه من تحويل تجاربه الفاشلة إلى فرص جديدة للنجاح والتطور (الشناوي، ١٩٩٤).

مصادر الدعم الاجتماعي:

استنادًا إلى مراجعة الأدبيات والدراسات المتعلقة بموضوع البحث، تبين وجود مصادر متنوعة ومتعددة للدعم الاجتماعي تلعب أدوارًا جوهرية في حياة الأفراد. إذ تتراوح هذه المصادر بين الأسرة والأصدقاء والزملاء والمؤسسات المجتمعية والهيئات الرسمية، وتؤثر بدرجات مختلفة في مستوى التكيف النفسي والرفاهية العامة للفرد (Ersoy & et al., 2025).

تختلف مصادر الدعم الاجتماعي، تتمثل مصادر الدعم الاجتماعي في "الأسرة، الأصدقاء، الأقارب، زملاء العمل (Emmons & Colby, 1995).
تتمثل فيما يلي:

١- الأسرة و الأقارب:

تُعدّ الأسرة أحد أهم مصادر الدعم الاجتماعي للفرد، إذ تضطلع بدور محوري في تقديم مختلف أشكال الدعم لأبنائها العاملين. فهي تسهم في تهيئة بيئة اجتماعية داعمة من خلال تشجيعهم على بناء علاقات إيجابية والتفاعل مع الآخرين والانفتاح على المجتمع الخارجي، مما يعزز الشعور بالانتماء والاستقرار النفسي.
كما تقدّم الأسرة دعماً نفسياً يتمثل في توفير أجواء يسودها الأمان والطمأنينة والابتعاد عن مصادر القلق والتوتر، إلى جانب ذلك، تقوم بدور إرشادي من خلال النصح والتوجيه والمساعدة في مواجهة المشكلات اليومية. ويؤكد الباحث كذلك على أهمية الأقارب - مثل الأعمام والأخوال وأبناء العمومة وذلك بوصفهم امتداداً للأسرة ومصدراً إضافياً للدعم الاجتماعي والعاطفي الذي يساعد الفرد العامل على التكيف مع ضغوط الحياة المهنية والاجتماعية (Blizzard, 2020).

٢- الأصدقاء:

يلعب الأصدقاء دورًا محوريًا في حياة الفرد من خلال ما يقدمونه من دعم اجتماعي وعاطفي في أوقات الحاجة، إذ تُعد العلاقات والروابط التي تجمع بينهم من أهم أشكال التفاعل الإنساني التي تقوم على التفاهم المتبادل والمساندة المستمرة. فالأصدقاء يُسهمون في التخفيف من الأعباء النفسية وإزالة مشاعر القلق والتوتر من خلال الإصغاء والمشاركة الوجدانية، كما يعملون على تعزيز الثقة بالنفس وبت روح التفاؤل والأمل في مواجهة التحديات. إضافةً إلى ذلك، يقدم الأصدقاء النصيحة والإرشاد والتوجيه في المواقف الصعبة، ويُسهمون في تنمية علاقات اجتماعية إيجابية تُعزز من مشاعر الانتماء للجماعة، مما ينعكس إيجابًا على التكيف النفسي والاجتماعي للفرد العامل (Zhang & et al.,2014).

٣- زملاء العمل:

تُعدّ مؤسسات العمل من أكثر الجهات قدرةً على تقديم أشكال متنوعة من الدعم الاجتماعي للعاملين، إذ تساهم في بناء علاقات إيجابية وروابط قائمة على الثقة المتبادلة بين المؤسسة وأفرادها، مما يُعزز الشعور بالانتماء والاستقرار. كما يمكن لهذه المؤسسات أن تقدم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال توفير أخصائيين مختصين يتابعون أوضاع العاملين ويساهمون في حل المشكلات التي تواجههم داخل بيئة العمل. بالإضافة إلى ذلك، تضطلع هذه المؤسسات بدورٍ مهم في تأهيل العاملين عبر برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى رفع كفاءاتهم المهنية، إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي والعاطفي، مما يُسهم في تحسين أدائهم العام وتحقيق رفاههم النفسي والاجتماعي (Wang & Qu,2022).

يُعدّ زملاء العمل والمجتمع من أهم مصادر الدعم الاجتماعي التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، إذ يُسهم زملاء العمل في خلق بيئة مهنية قائمة على التعاون والتكامل، مما يخفف من الضغوط الوظيفية ويعزز الرضا الوظيفي والانتماء للمؤسسة. كما يوفر الزملاء الدعم المعنوي والمساندة في مواجهة التحديات المهنية من خلال تبادل الخبرات والمشورة والتشجيع المستمر (Jolly & et al.,2020).

نظريات مفسرة للدعم الاجتماعي:

أولاً: نظرية الإرشاد متعدد الوسائل:

تستند هذه النظرية في أسسها المفاهيمية إلى مجموعة من النظريات النفسية مثل نظرية أدلر، وإريكسون، والعلاج بالواقع لروجرز، والسيكودراما، إضافةً إلى نظرية التعلم الاجتماعي لباندورا. ويرى لازاروس أن سلوك الأفراد يتشكل من خلال عملية التعلم التي تقوم أساساً على مبدأ الاقتران بوصفه أحد المبادئ الجوهرية في التعلم، كما يحدث التعلم أيضاً من خلال النمذجة، أي عبر ملاحظة الفرد لسلوك الآخرين وتقليده، سواء كان هذا السلوك إيجابياً أم سلبياً. وخلال عملية التعلم الاجتماعي، يكتسب الأفراد العديد من ردود الأفعال الدفاعية، التي تهدف غالباً إلى تجنب القلق والاكتئاب والألم. ومن ثم فإن الأفراد يتفاعلون مع بيئتهم كما يدركونها، وليس بالضرورة كما هي في الواقع الموضوعي (بلان، ٢٠١٥).

ثانياً: نظرية التعلم الاجتماعي:

تُعرف هذه النظرية باسم نظرية التعلم بالملاحظة والتقليد أو نظرية التعلم بالنمذجة، والتي قام بتطويرها العالم ألبرت باندورا. وتفترض هذه النظرية أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته يعيش ضمن جماعات يتفاعل، معها، فيؤثر فيها و يتأثر بها، إذ يقوم الفرد بملاحظة سلوكيات وعادات واتجاهات الآخرين في البيئة المحيطة به، ثم يعمل على تعلمها من خلال الملاحظة والتقليد، حيث يُعتبر هؤلاء الآخرون نماذج يُحتذى بها في السلوك. وترى النظرية أن حدوث التعلم بالملاحظة يتطلب توفر أربعة عناصر أساسية، هي: الانتباه، والاحتفاظ، والاستخراج الحركي، والدافعية. كما يمكن أن يتم التعلم الاجتماعي من خلال التفاعل المباشر كما في المواقف الحياتية اليومية، أو من خلال التفاعل غير المباشر عن طريق وسائل الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة (الزغلول، ٢٠١٠).

نظرية علم النفس الفردي:

يرى أدلر أن الاهتمام الاجتماعي يعدّ محوراً أساسياً في تكوين الشخصية السوية، إذ إنّ الفرد يدرك ذاته كجزء من الجماعة، ويسعى دائماً إلى إيجاد مكانة له داخل الأسرة والمجتمع. ويبدأ هذا الشعور بالانتماء منذ مرحلة الطفولة، حيث يبحث الفرد عن الارتباط

بالآخرين، ويرى أدلر أن مكانة الفرد في المجتمع تمنحه الإحساس بالأمن والانتماء، بينما يؤدي غياب هذا الشعور أو ضعف الارتباط بالجماعة إلى نشوء القلق والشعور بالعزلة (أبو أسعد، ٢٠١٥).

ثانياً الاضطرابات النفسية:

تُعَدُّ الاضطرابات النفسية من القضايا الصحية والاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على توازن الفرد النفسي وقدرته على التكيف مع ضغوط الحياة اليومية، وتتعاكس هذه الاضطرابات سلباً على الأداء الوظيفي والعلاقات الاجتماعية للفرد، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات الغياب والتوتر داخل بيئة العمل، كما تُبرز الحاجة الماسة إلى توفير دعم نفسي واجتماعي فعال للعاملين للحد من آثار هذه الاضطرابات وتعزيز صحتهم النفسية (Agarwal & Sharma, 2011).

يواجه العاملون في المؤسسات الصحية، الكثير من ضغوطات العمل التي قد تؤدي إلى ظهور أعراضاً مرتبطة بهذا المستوى من التوتر النفسي والإرهاق المستمرين، إذ يعاني الطاقم من القلق والأرق والاكتئاب، وهي عوامل يمكن أن تزيد من مخاطر المشاكل الصحية النفسية (Arnetz, 2001).

١ - القلق:

مفهوم القلق:

يُعرَّف القلق لغةً و اصطلاحاً من خلال العديد من الأدباء والعلماء على النحو التالي:
القلق لغةً:

يُعرَّف القلق في المعجم الوسيط بأنه الهم، والأرق، والاضطراب، والانزعاج، وعدم الاستقرار في مكان واحد على حال واحد. كما يشير مصطلح القلق في المعاجم العربية إلى حالة الانزعاج والحركة المضطربة (ابن منظور، ١٩٨٨).

القلق اصطلاحاً:

اختلف علماء النفس في تعريف مفهوم القلق، وتعددت تفسيراتهم حول طبيعته وأسبابه وطرق التعامل معه، حيث تناول كل اتجاه نفسي هذا المفهوم من زاويته الخاصة، وعلى الرغم من هذا التباين في الرؤى، إلا أن هناك اتفاقاً عاماً بينهم على أن القلق يُعدُّ العنصر الأساسي في نشأة الاضطرابات النفسية والعقلية، ويمثل نقطة الانطلاق لفهمها

وتشخيصها، وفيما يلي عرض لأبرز التعريفات التي تناولت هذا المفهوم من منظور علم النفس:

يُعرّف القلق بأنه حالة شعورية غامضة تتسم بالخوف والتوجس والتوتر، دون أن يكون للفرد إدراك واضح لمصدر هذا الخوف، وغالبًا ما ترافقها أعراض جسدية متكررة في صورة ضيق الصدر، وصعوبة التنفس، وتسارع نبضات القلب (نور الدين، ٢٠٠٩). يُعرّف القلق بأنه شعور بالخوف والترقب تجاه المستقبل، وما قد يتضمنه من أحداث أو مخاطر محتملة تُهدد استقرار الإنسان ووجوده (Sharp & et al., 2007).

يُعرّف القلق بأنه حالة نفسية يصاحبها إحساس بوجود خطر يهدد الفرد، وينتج عنها توتر انفعالي يُرافقه اضطرابات فسيولوجية متعددة (غزالي، ٢٠١٦).

يرى الباحث أن القلق يمثل حالة نفسية معقدة تنشأ نتيجة شعور الفرد بوجود تهديد محتمل أو خطر يهدد استقراره النفسي أو الاجتماعي، ويصاحبه توتر داخلي واضطرابات جسدية وانفعالية قد تؤثر في سلوك الفرد وأدائه اليومي.

أعراض القلق:

يُعدّ القلق نموذجًا مميزًا للتغيرات التي تطرأ على الإنسان في حالات التوتر أو الذعر، إذ يؤثر في الجوانب الثلاثة الأساسية للشخصية، وهي: الجانب الجسمي العضلي، والجانب الانفعالي أو الوجداني، وجانب التفكير والإدراك، وتتجلى أعراض القلق في مظاهر متعددة، منها ما يظهر على الصعيد النفسي والانفعالي، ومنها ما يتجلى على المستوى الجسمي (عثمان، ٢٠٠١).

وسيقوم الباحث فيما يلي بعرض أبرز هذه الأعراض في كل جانب:

١- الأعراض النفسية:

تتضمن أعراض القلق مجموعة من المشاعر والسلوكيات السلبية، مثل القلق العام والانشغال المفرط بالصحة، والشعور بعدم الاستقرار وفقدان الأمل والراحة النفسية، إلى جانب الحساسية الزائدة وسرعة الانفعال والخوف الشديد دون معرفة مصدر، كما يعاني الفرد من الإحساس بانعدام الأمان، والضيق، وتوهم المرض، وصعوبة التركيز والانتباه، وضعف الثقة بالنفس والشعور بعدم الطمأنينة، إضافةً إلى الرغبة في الهروب من

مواجهة المواقف، وتوقع حدوث أمور سلبية غامضة، مع الميل إلى الشك والتردد في اتخاذ القرارات (حسين، ٢٠٠٩).

يُعدّ القلق حالة انفعالية تتجلى في الشعور بالخوف والتوجس وعدم الراحة الداخلية، مع ترقب وقوع أمر مكروه دون سبب واضح،

وينتج عن ذلك تشتت الانتباه، وضعف القدرة على التركيز، وكثرة النسيان، والأرق وصعوبة النوم، إضافة إلى التوتر والتهيج العصبي والشعور بالاختناق، وقد يصاحبه أحلام وكوابيس مزعجة تسيطر عليها مشاعر القلق والتوجس المستمر (محفوظ، ٢٠٠٠).

٢- الأعراض الجسدية:

تتمثل الأعراض الجسدية للقلق في الضعف العام، وانخفاض مستوى الطاقة والنشاط والمثابرة، إضافة إلى برودة الأطراف، وتوتر العضلات، وزيادة النشاط الحركي، وقد تظهر أحياناً على شكل نوبات أو أزمات عصبية حركية تعكس حالة التوتر الداخلي التي يعاني منها الفرد (زهران، ١٩٩٧).

هناك أعراض الجسدية للقلق تظهر على الفرد المصاب بالقلق أعراض جسدية متعددة مثل التعرق المفرط وخاصة في الكفين، وارتعاش اليدين، وبرودة الأطراف، وشحوب الوجه، وسرعة النبض والخفقان، وارتفاع ضغط الدم، كما قد يعاني من صداع مستمر واضطرابات في المعدة، وفقدان الشهية، والدوار، والغثيان أو القيء، والشعور بالضيق في الصدر وصعوبة التنفس، و نقص في الطاقة و لنشاط، وهي مؤشرات تعكس التفاعل الجسدي الحاد لحالة القلق (Zaleski, 1996).

٣- الأعراض المعرفية:

تنتم هذه الأعراض أيضاً بخصائص معرفية مميزة، حيث يظهر الأفراد ميلاً إلى التطرف في الحكم على المواقف باتجاه واحد، إضافة إلى التشدد في التفكير ومواجهة المواقف المختلفة بأسلوب واحد متكرر، كما يتبنون معتقدات غير منطقية تقوم على التسلط والجمود العقائدي، ويظهر لديهم اعتماد مفرط على الأقوياء ونماذج السلطة في تفسير الأحداث واتخاذ القرارات (سرحان، ٢٠٠٨).

٤- الأعراض الاجتماعية:

يظهر لدى الأفراد القلقين في ظل هذه الأعراض ميل واضح نحو العزلة الاجتماعية، إذ يواجهون صعوبة في التوافق مع الآخرين في كثير من المواقف، ويميلون إلى الابتعاد عن التفاعلات الاجتماعية. كما يتسمون بالنقد الذاتي المستمر، وغالبًا ما يتخذون قرارات سريعة دون تنفيذها فعليًا، مما يعكس حالة من التردد والاضطراب الداخلي (عبد الستار، ١٩٩٤).

مستويات القلق:

يقسم بازوفيتز (Basaowiter) مستويات القلق إلى ثلاثة مستويات وهي كالتالي:

١- المستوى المنخفض للقلق:

يُحدث هذا النوع من القلق حالةً من الاستثارة العامة أو التنبيه الداخلي لدى الفرد، حيث تزداد درجة التيقظ والانتباه، ويرتفع مستوى الحساسية تجاه المثيرات والأحداث الخارجية، كما تزداد قدرة الفرد على المقاومة والاستعداد لمواجهة المواقف أو الأخطار المحتملة في بيئته. ويُعدّ هذا المستوى من القلق بمثابة إشارة إنذار مبكر لخطر وشيك الحدوث، إذ يعمل على تهيئة الفرد وتأهيله نفسيًا وجسديًا للتعامل مع الموقف. ويُعتبر هذا النمط من القلق طبيعيًا ووظيفيًا، لأنه يؤدي دورًا تكيفيًا يتمثل في تنبيه الفرد واستعداده لمواجهة ما قد يتعرض له من تهديدات أو مواقف صعبة (عبد الحميد، ٢٠٠١).

٢- المستوى المتوسط للقلق:

يصبح الفرد في هذا المستوى من القلق أقل قدرة على ضبط استجاباته وانفعالاته، إذ يفقد سلوكه مرونته وتلقائيته، ويغلب عليه الجمود والتصلب في التعامل مع المواقف المختلفة. كما تقل قدرته على الابتكار واتخاذ القرارات المناسبة، ويشير هذا المستوى إلى أن الفرد يفقد قدرًا من السيطرة على تصرفاته نتيجة التوتر الزائد، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على قدرته على التكيف مع المواقف اليومية (أحمد و آخرون، ٢٠٢٤).

٣- المستوى المرتفع للقلق:

يتعرض التنظيم السلوكي للفرد في هذا المستوى إلى اضطراب واضح، حيث قد يلجأ إلى أساليب سلوكية غير ملائمة للمواقف التي يواجهها، ويفقد قدرته على التمييز بين المثيرات الضارة وغير الضارة. كما تظهر عليه علامات ضعف التركيز وتشتت الانتباه

وسرعة الانفعال، مما يؤدي إلى تصرفات عشوائية وغير منضبطة تعكس حالة من الاضطراب النفسي والانفعالي (Abdel & Salwa, 2021).

في هذا المستوى يحدث تدهور وانهيار واضح في التنظيم السلوكي للفرد، مما يجعله عاجزاً عن التمييز بين المثيرات الضارة وغير الضارة. وتنعكس هذه الحالة في سلوك المصاب بالقلق العصابي من خلال مظاهر مثل الذهول وتشتت التفكير والشعور بالوحدة وسرعة الانفعال والعشوائية في التصرفات، وهو ما يدل على فقدان السيطرة على الاستجابات السلوكية والانفعالية (محمد، ٢٠٢١).

النظريات المفسرة للقلق:

١ - نظرية التحليل النفسي:

يُعدّ "فرويد" Freud رائد مدرسة التحليل النفسي من أوائل من تحدثوا عن القلق في علم النفس، بل ويرى البعض أن هذا المفهوم لم يشع استخدامه إلا عندما شاع في كتابات "فرويد"، حيث يعود الفضل إليه في توجيه علماء النفس إلى الدور الهام الذي يلعبه القلق في حياة الإنسان. (Rachman, 1998)

- (فرويد) (Frued)

يرى فرويد أن القلق يُعدّ استجابة نفسية تنشأ نتيجة شعور الفرد بوجود خطر يهدده، سواء كان هذا الخطر حقيقياً أو متخيلاً، وتخفي أعراض القلق أو تقلّ حدتها عندما يزول مصدر التهديد أو ينتهي الموقف المسبب له، لكنها تعود للظهور من جديد عند تعرض الفرد للحالة أو الموقف ذاته مرة أخرى (الشناوي، ٢٠٠٠).

٢ - النظرية السلوكية:

تركز النظرية السلوكية على تفسير القلق من خلال عملية التعلم الشرطي، حيث يرى أصحابها مثل واطسن (Watson) وسكنر (Skinner) أن تعلم السلوك المرضي، بما في ذلك القلق والخوف، يتم بالطريقة نفسها التي يُتعلم بها السلوك السوي. فالفرد يكتسب استجابته للقلق أو الخوف نتيجة اقتران المثير الشرطي بالمثير الطبيعي، مما يجعل القلق دافعاً مكتسباً (Rachman, S. 1988)

- بافلوف Pavlov (الإشراط الكلاسيكي):

يرى بافلوف (Pavlov) أنَّ القلق ينشأ عندما يشعر الفرد بوجود منبه شرطي يرمز إلى خطرٍ ما، يشبه في تأثيره ردَّ الفعل الذي تولّد لديه سابقاً نتيجة منبه طبيعي ارتبط بصدمة حقيقية.

وبهذا، فإنَّ القلق يمثل استجابة شرطية مكتسبة تحدث عندما يتعرض الفرد لمواقف أو مثيرات مشابهة لتلك التي ارتبطت سابقاً بالتجارب المؤلمة أو المهدّدة. كما أكّد بافلوف على آلية التعويض التي قد يلجأ إليها الفرد في مواجهة المنبهات الشرطية) (كفاي، ١٩٩٠).

٣- النظرية المعرفية:

تمثل النظرية المعرفية اتجاهاً قوياً في علم النفس المعاصر، إذ كان لها تأثير واسع على العديد من المدارس النفسية الأخرى، مثل سوليفان في المدرسة التحليلية، وباندورا في المدرسة السلوكية، وقد تنوعت الاتجاهات المعرفية واختلفت رؤاها في تفسير السلوك الإنساني، غير أنها تشترك في التأكيد على أن العمليات المعرفية الداخلية و تشمل؛ التفكير، والتفسير، والإدراك (عبد الرحيم، ٢٠١٦).

- بيك (Beck):

أشار بيك أن القلق يظهر لدى الفرد كاستجابة عاطفية نتيجة الخوف الناتج عن التفكير الخاطئ، وتوقع المخاطر التي تسيطر على أفكاره، والتي قد تؤثر على صحته، وأسرته، وأدائه الاجتماعي، والمهني. ويعتبر التفكير السلبي لدى الأفراد المصابين بالقلق من الأخطاء المعرفية، حيث يتوقعون دائماً أسوأ النتائج الممكنة للأحداث. كما أن المبالغة المستمرة في تقدير المخاطر المحتملة في المستقبل تسبب للفرد قلقاً، نتيجة تشكيكه الدائم في قدرته على مواجهة الأحداث أو التعامل معها (بلكيلاني، ٢٠٠٨).

- سبيلبيرجر (Spielberger):

تُعد نظرية سبيلبيرجر أساساً للتمييز بين نوعين من القلق: القلق كصفة (Trait Anxiety) والذي يُعتبر استعداداً طبيعياً أو ميلاً سلوكياً يعتمد على الخبرات السابقة للفرد، والقلق كحالة (State Anxiety)، والذي يعتمد من وجهة نظره على الظروف الضاغطة المحيطة بالفرد. ويربط سبيلبيرجر بين الضغط النفسي وقلق الحالة، معتبراً أن

الحالة القلقة ناتجة عن الضغط المستمر، بينما يستبعد الربط بين الضغط والقلق كصفة، حيث يُعد القلق في هذه الحالة جزءًا من سمات شخصية الفرد (دافيدوف، ٢٠٠٠).

٤- النظرية الإنسانية:

نشأ القلق لدى أصحاب هذه النظرية، مثل مازلو وروجرز (Maslow & Rogers)، نتيجة الخوف من المستقبل وما يترتب عليه من أحداث قد تهدد الوجود الإنساني. كما يظهر شعور القلق لدى الإنسان عندما يواجه تعارضًا بين الذات الواقعية والذات المثالية، أي بين إمكانياته وطموحاته، وبين ما يعيشه فعليًا وبين تصورات ومفهومه لذاته.

٢- الاكتئاب:

مفهوم الاكتئاب:

يُعرف الاكتئاب لغةً و اصطلاحاً من خلال العديد من الأدباء والعلماء على النحو التالي:

الاكتئاب لغةً:

يذكر لسان العرب أن كلمة "الاكتئاب" في اللغة العربية تشتق من الفعل الثلاثي كَاب، ويشير هذا الفعل إلى اسم كوبة، والذي يعني سوء الحال والانكسار نتيجة الحزن. ويُقال أيضًا: اكتئب اكتئابًا، أي حزن واغتم وانكسر (ابن منظور، ١٩٨٨).

الاكتئاب اصطلاحاً:

يُعدّ الاكتئاب من الاضطرابات الأولية للعواطف، حيث يتطلب تشخيصه استيفاء ثلاثة معايير رئيسية: أولها المزاج المزعج، كأن يكون المريض حزينًا أو يشعر باليأس؛ وثانيها وجود خمسة أعراض إضافية على الأقل، مثل قلة الشهية، واضطرابات النوم، وانخفاض الطاقة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات المشاعر والإثارة؛ وثالثها استمرار هذه الأعراض لمدة شهر على الأقل، مع سرعة التفكير أو التفكير الانتحاري. ولا تكون هذه الأعراض ناجمة عن مرض آخر مختلف (Lawlor, 2012).

يُعد مجموعة من السلوكيات المرحلية التي تتميز بالهبوط الحركي واللفظي، والحزن، والبكاء، وفقدان الاهتمام بالأشياء، واضطرابات النوم، وفقدان الشهية، وانخفاض الثقة بالنفس (المسحر، ٢٠٠٧).

نشأ الاضطرابات الاكتئابية أساساً على الاضطرابات المعرفية. وقد فسّر Beck الاكتئاب والعوامل المؤثرة فيه من خلال ثلاثة مفاهيم أساسية، تمثلت في المخططات المعرفية، وهي مفاهيم مطلقة للفرد وخبراته السابقة التي توجه سلوكه. لكن هذه المخططات قد تكون مشوهة وغير واقعية لدى الشخص المكتئب، مما يقوده إلى التفكير بطريقة غير عقلانية. وتتصف هذه المخططات أو الأخطاء المعرفية بأنها أشكال تمثيل غير ملائمة للمعلومات، وتشمل استنتاجات عشوائية، وتجريدات انتقائية، وتعميمات مفرطة، ومبالغات، وتفكير أخلاقي مطلق، وتخصيصات. كما أن طريقة التفكير السلبي حول الذات والمستقبل والمحيط تسهم في الإصابة بالاكتئاب، وهو ما أطلق عليه Beck اسم "الثالوث أو المثلث المعرفي" (رضوان، ٢٠٠٣).

أعراض الاكتئاب:

١ - الأعراض النفسية:

تتمثل الأعراض النفسية للاكتئاب في مشاعر اليأس والحزن الشديد، وتقلب المزاج، وضعف القدرة على ضبط النفس. كما يعاني الفرد من انخفاض تقدير الذات، وفقدان الثقة بالنفس، والقلق والتوتر المستمرين. ويظهر أيضاً الأرق، والانطوائية، والشروود الذهني، والنظرة السوداوية للحياة، إلى جانب مشاعر الذنب التي قد تتطور في بعض الحالات إلى أفكار أو محاولات انتحارية (الشاذلي، ٢٠٠٠).

٢ - الأعراض الجسدية:

تتمثل الأعراض الجسدية للاكتئاب في الصداع، والإمساك، وآلام الظهر، والشعور بالتعب عند بذل أي مجهود. كما يشعر الفرد المكتئب بانقباض الصدر، وفقدان الشهية أو تغير الوزن سواء بالنقص أو الزيادة. وتشمل الأعراض أيضاً نقص الرغبة الجنسية، واضطراب الدورة الشهرية لدى النساء، بالإضافة إلى الضعف العام والشعور المبالغ فيه بالمرض (توهم المرض) (الميلادي، ٢٠٠٤).

٣ - الأعراض الاجتماعية:

تظهر لدى الأفراد المكتئبين أعراض اجتماعية تشمل صعوبة تكوين علاقات جدية، وقلة التفاعل مع الآخرين، والافتقار إلى المشاعر الإيجابية. كما يعانون من الشعور بالقلق في المواقف الاجتماعية، وعدم الرضا عن العلاقات القائمة مثل الصداقة أو

الزواج أو الزمالة، إلى جانب مشاعر الانسحاب والإهمال العام بالنظافة الشخصية (المعاينة، ٢٠٠٢).

أنواع الاكتئاب:

قسمت الجمعية الأمريكية للطب النفسي (2013) مستويات الاكتئاب في الدليل التشخيصي الخامس (DSM-5) إلى ثلاثة أقسام:

١. **الاكتئاب البسيط (Mild)** يعد أخف مستويات الاكتئاب، حيث تكون أعراضه قليلة إن وجدت، ويمكن التحكم بها، وتؤدي إلى انخفاض طفيف في الأداء الاجتماعي أو المهني للفرد.

٢. **الاكتئاب المتوسط (Moderate)** تكون أعراضه متوسطة من حيث شدتها وتأثيرها على فعالية الفرد وأدائه الاجتماعي أو المهني.

٣. **الاكتئاب الشديد (Severe)** يعد هذا المستوى من أشد مستويات الاكتئاب، إذ تكون الأعراض حادة ومحبطة بشكل خطير، وتتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب للتشخيص، ولا يمكن التحكم بها بسهولة، وتؤثر بشكل واضح على الأداء الاجتماعي والمهني للفرد. (American Psychiatric Association, 2013)

النظريات المفسرة للاكتئاب:

١ - نظرية التحليل النفسي:

أشار كل من فرويد وأبراهام إلى تفسير الاكتئاب باعتباره نكوصًا للمرحلة الفموية للطفل. ووفقًا لهذه النظرية، يحمل الفرد المكتئب مشاعر متناقضة تجاه الحب الأول له، والذي يتمثل عادة في الأم. نتيجة لمشاعر الإحباط وعدم إشباع حاجة الحب في المراحل الأولى من نمو الفرد، تتولد لديه مشاعر متناقضة تجمع بين الحب والكراهية، والالتحام والنبيذ. ومع تقدم العمر، وعند تعرض الطفل لمواقف صادمة مثل خيبة الأمل أو فقدان عزيز، ينكص إلى هذه الحاجة الأولية، وتظهر عمليات دفاعية شعورية مثل الإسقاط والنكوص والإدماج للتعامل مع هذه المشاعر المتناقضة (عكاشة، ٢٠٠٣).

يشير فرويد في اكتشاف أن الإنسان يولد مزودًا بطاقة سماها الليبيدو، وهي الطاقة التي تحرك الشخصية وتدفعها نحو اتجاهات مختلفة تؤثر على الصحة النفسية أو

المرض. وتحتوي الشخصية وفق فرويد على ثلاث مكونات أساسية تساعد في فهم وتفسير الاكتئاب:

١. **الهو (Id):** يمثل الجانب الغريزي المرتبط بالنزعات اللامنطقية لدى الشخص.
 ٢. **الأنا (Ego):** الجزء العقلاني الذي يوجه الشخص لإشباع رغبات **الهو** بما يتناسب مع الواقع الخارجي.
 ٣. **الأنا الأعلى (Superego):** الضمير أو الرقيب الداخلي للشخص، ويعمل وفق مبدأ الواقع، موضحاً القيم والمعايير الأخلاقية.
- وبين فرويد أن العلاقة بين هذه المكونات الثلاث تتميز بالصراع، وأن تطور الشخصية أو إصابتها بالأمراض النفسية يحدث نتيجة هذا الصراع. وقد اعتبرت النظرية الفرويدية أن الأمراض النفسية، بما فيها القلق والاكتئاب، هي نتاج الصراعات التي يمر بها الشخص في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويرى المحللون النفسيون أن التفسيرات الواعية التي يقدمها المريض لما يعانيه من قلق أو اكتئاب تمثل جزءاً ضئيلاً من الأسباب الحقيقية، بينما الجزء الأكبر من هذه الاضطرابات يكون مدفوناً في اللاشعور. ومن هنا، يكون الهدف الرئيس من العلاج بالتحليل النفسي هو إزاحة الستار عن الدوافع اللاشعورية المكبوتة لمعالجة الاكتئاب والاضطرابات النفسية المختلفة (إبراهيم، ١٩٩٨).

ترى نظرية التحليل النفسي أن الإصابة بمختلف الاضطرابات النفسية، بما فيها الاكتئاب، تعود إلى الصراع الذي ينشأ في مرحلة الطفولة المبكرة بين مكونات الشخصية الثلاث (**الهو، الأنا، الأنا الأعلى**). وعند فشل هذه المكونات في حل هذا الصراع، ينشأ عنه الاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى (Armstrong, 2011).

٢- نظرية التحليل النفسي:

يرى السلوكيون أن من أسباب الاكتئاب افتقار الأفراد للتدعيم الخارجي والإشباع العاطفي، وأن هؤلاء الأفراد غالباً ما يفتقرون إلى الكفاءة في المهارات الاجتماعية اللازمة للحصول على التقدير والاعتراف الضروري في حياتهم. كما أنهم يميلون إلى استقبال التدعيم السلبي أكثر من التدعيم الإيجابي. وعند تعرضهم لأحداث ضاغطة مستمرة،

تظهر لديهم أعراض اللامبالاة، تليها مشاعر العجز واليأس، ثم ظهور باقي أعراض الاكتئاب (عبد المسيح، ٢٠٠١).

وصفت النظرية السلوكية الاكتئاب بأنه فقدان لعملية تدعيم السلوك. وفقاً لـ فيرستر (Ferster)، فإن السلوك المرضي هو نتيجة مباشرة لتفاعل الفرد مع البيئة، ومحصلة تعليمية لمسيرة حياته. ويرى فيرستر أن الاكتئاب يمكن تقليله تدريجياً من خلال التدعيم الإيجابي للسلوك. من جهته، يؤكد لازاروس (Lazarus) أن الاكتئاب ينشأ نتيجة عدم كفاية المدعمات للسلوك. وهنا يتفق الاثنان على أن الاكتئاب هو حالة تظهر وتزداد وضوحاً عند نقص التدعيم، مما يؤدي إلى ضعف الأداء في الأدوار التي يقوم بها الفرد (غريب، ٢٠٠٢).

كما يرى أصحاب النظرية السلوكية أن الاكتئاب يمثل خبرة نفسية سلبية ومؤلمة، وهو في الواقع تكرار لخبرات سبق للفرد أن تعلمها أو صادفها، ولم يتمكن من حلها أو التخلص منها من ذهنه (إبراهيم، ٢٠٠٣).

٣- النظرية المعرفية:

يرى بيك (1967)، مؤسس هذه النظرية، أن الاكتئاب اضطراب عاطفي ناتج عن إدراكات معرفية. وتسيطر على إدراكات الأفراد المكتئبين عمليات مفرطة في الحساسية تحدد طريقة استجاباتهم للمواقف. ويعتقد بيك أن طريقة تفكيرهم مشوشة وغير واقعية، كما أنهم يمتلكون فهماً خاطئاً للأحداث نتيجة خلل في تنظيم أفكارهم. وينعكس ذلك في امتلاكهم آراء ومعتقدات سلبية عن أنفسهم، والعالم، والمستقبل؛ حيث يرون أنفسهم بلا قيمة، ويعتبرون العالم غير عادلاً، ويستشفون مستقبلاً مظلماً بلا أمل (بوقري، ٢٠٠٩).

قسم بيك المفهوم الخاطئ للشخص المكتئب إلى ما يسمى بـ الثلاث المعرفي (Cognitive Triad)، والذي يشمل معرفة المريض أو منظوره لعالمه، ومعرفته لذاته، ومعرفته لمستقبله. كما يمتلك الشخص المكتئب مجموعة من الخصائص الإدراكية السلبية، والتي تتمثل في انخفاض احترام الذات، ولوم الذات، ووجود مطالب مفرطة على الذات، بالإضافة إلى الرغبات العدائية تجاه الذات (المدني، ٢٠١٠).

تشير النظرية المعرفية أن الاكتئاب ينشأ نتيجة عن اضطراب في التفكير ونمط تفكير غير منطقي لدى الفرد. ومع ذلك، يظهر قصور في هذه النظرية و ذلك لكونها لم

تتطرق إلى أهمية دور العوامل البيئية والأحداث الضاغطة في نشوء الاكتئاب أو تفاقمه (Reham, L., 2015).

٤- النظرية الطبية النفسية:

تهتم النظرية الطبية النفسية بالأعراض الجسدية الناتجة عن الاكتئاب وارتباطها بالاضطرابات الوظيفية للجسم، مثل أي خلل يصيب النظام العصبي أو الهرموني أو الكيميائي، دون التركيز على الأسباب النفسية العميقة وراء هذه الأعراض. وتستخدم هذه النظرية وسائل علاجية طبية مثل: العلاج الكيميائي (الأدوية) والعلاج بالصدمات الكهربائية (حسين، ٢٠٠٢).

٥- نظرية العجز المتعلم (سيلجمان، ١٩٧٥):

يرى سيلجمان أن مواجهة الفرد للأحداث الكارثية والمشقة المستمرة تؤدي إلى تلبد مشاعر الفرد، والشعور باللامبالاة والانطواء. ويتبع ذلك الإحساس باليأس والعجز، ثم ظهور بقية أعراض الاكتئاب الأخرى (عكاشة، ٢٠١٥).

يرى الباحث أن الدعم الاجتماعي يلعب دورًا حيويًا في الحد من الاضطرابات النفسية، وخاصة القلق والاكتئاب. يساعد الدعم الاجتماعي الأفراد على مواجهة الضغوط والتحديات الحياتية بفعالية أكبر. كما يساهم في تعزيز الشعور بالأمان والانتماء، وتقليل مشاعر العزلة واليأس.

ويسعى الباحث في الجزء الميداني إلى التعرف على علاقة الدعم الاجتماعي بالاضطرابات النفسية لدى عينة الدراسة، من خلال جمع البيانات وتحليلها لتحديد العلاقة بين الدعم الاجتماعي والصحة النفسية.

الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة العربية والأجنبية متغيرات الدراسة الحالية:

أولاً: دراسات تشير إلى العلاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق:

هدفت دراسة (Peter & et al., 2017) إلى تقييم العلاقة بين الدعم الاجتماعي واضطرابات القلق لدى المراهقات الحوامل، حيث أجريت دراسة مقطعية على عينة مكونة من (٨٧١) فتاة حامل تتراوح أعمارهن بين (١٠ و ١٩) عامًا، تلقين الرعاية السابقة للولادة ضمن النظام الصحي العام في المناطق الحضرية بمدينة بيلوتاس، بولاية

ريو غراندي دو سول، جنوب البرازيل. تم قياس الدعم الاجتماعي المدرك باستخدام مقياس الدعم الاجتماعي للدراسة الطبية للنتائج، وتم تشخيص اضطرابات القلق من خلال المقابلة النفسية المصغرة الدولية، كما جُمعت البيانات الاجتماعية والديموغرافية باستخدام استبيان ذاتي، بلغت نسبة انتشار اضطرابات القلق بين المراهقات الحوامل 13.6% وأظهرت النتائج أن من يعانون من اضطراب القلق أبلغن عن انخفاض في مستويات الدعم الاجتماعي، كما أظهرت مستويات دعم أقل في الأبعاد الوجدانية والمعلوماتية والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، توصلت الدراسة إلى أن للدعم الاجتماعي عاملاً وقائياً ضد اضطرابات القلق لدى المراهقات الحوامل، حيث يُسهم في تعزيز الصحة النفسية وتحسين القدرة على التكيف مع ضغوط الحمل.

هدف بحث (محمد، ٢٠٢٢) إلى التعرف على فاعلية برنامج لتنمية مهارات الدعم النفسي الاجتماعي الأولي خلال الأزمات وخفض مستوى قلق المستقبل لدى أمهات أطفال الروضة في ظل جائحة كورونا، وقد تم التحقق من فروض البحث من خلال اختبار مهارات الدعم النفسي الاجتماعي خلال الأزمات وبرنامج تنمية مهارات الدعم النفسي الاجتماعي، ومقياس قلق المستقبل في ظل جائحة كورونا لدى أمهات أطفال الروضة، استخدم البحث المنهج شبه التجريبي ذي تصميم المجموعة الواحدة المعتمد على القياسين القبلي والبعدي وذلك لملائمته لطبيعة عينة البحث وأهدافه، أشارت نتائج القياسات القبلي والبعدي، والتبعي لاختبار مهارات الدعم النفسي الاجتماعي خلال الأزمات إلى فاعلية البرنامج في تنمية مهارات الدعم النفسي الاجتماعي الأولي لدى أمهات أطفال الروضة خلال الأزمات، وإلى التأثير الكبير للبرنامج في تنمية هذه المهارات لدى الأمهات. كما أشارت نتائج مقياس قلق المستقبل، وحجم الأثر الذي تراوح ما بين المتوسط والكبير إلى فاعلية واستمرارية أثر البرنامج في خفض حدة قلق المستقبل لدى الأمهات.

هدفت دراسة (جريفي، ٢٠٢٣) إلى تعريف الدعم النفسي الاجتماعي، مصادره وأنواعه تعريف قلق المستقبل وأسبابه، التعرف على مساهمة الدعم النفسي الاجتماعي في خفض قلق المستقبل لدى أمهات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد،

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن تقديم الدعم النفسي الاجتماعي لأطفال المصابين بهذا الاضطراب، يلعب دوراً مهماً في تجاوز عدة مشاكل لديهم، إذ يمكنهم من اكتساب مهارات نفسية واجتماعية، لمساعدة أطفالهم على الاندماج في المجتمع، وأوصت الدراسة بضرورة توظيف مجموعة كافية من الأخصائيين النفسيين في المستشفيات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

هدفت دراسة (Yang & et al.,2025) إلى استكشاف العلاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى طلاب الجامعات، بالإضافة إلى الدور الوسيط للمرونة والتأثير المعتدل للتمارين البدنية. أُجريت دراسة استقصائية لقياس مستويات الدعم الاجتماعي والمرونة والتمارين البدنية والقلق لدى ١٠٩٧ طالباً جامعياً من جامعتين في مقاطعة هونان. جُمعت ٩٩٧ استبياناً صالحاً، منها ٥٦٢ من الطلاب الذكور و٤٣٥ من الطالبات، وقد كشف التحليل الإحصائي أن الدعم الاجتماعي يتنبأ سلباً بالقلق بشكل كبير، وأن الدعم الأسري هو الأبرز. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعديل تأثير الدعم الاجتماعي على القلق من خلال التمارين البدنية. تلعب المرونة دوراً وسيطاً مهماً بين الدعم الاجتماعي والقلق. يمكن أن يساعد تعزيز المرونة من خلال التمارين البدنية في منع السلوكيات المرتبطة بالقلق لدى طلاب الجامعات وتحسين صحتهم النفسية بشكل عام.

هدفت دراسة (Zhang & He,2025) إلى تقييم الحالة الراهنة لقلق الشخصية بين طلاب الجامعات الصينيين، وللتحقق من فعالية الدعم الاجتماعي في تخفيف هذا القلق، اتبعت الدراسة منهجاً طويلاً مع تتبّع على مدى فترة زمنية، مستخدمة مقاييس مثل مقياس GAD-7، ومقياس القلق المزمن لطلاب الجامعات (TAUS)، ومقياس الدعم الاجتماعي (SSRS)، شملت العينة عدداً كبيراً من طلاب الجامعات الصينيين، وقدّرت نسبة أولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق بـ 32.4 ٪، موزعين على أنواع مثل قلق العمل، القلق الاجتماعي، قلق الدراسة، القلق الصحي، والقلق من التقييم السلبي، من النتائج أن الأنشطة المباشرة للدعم الاجتماعي، مثل تنظيم الأندية والجلسات الجماعية العلاجية، يمكن أن تقلل من انتشار هذه الأنماط الخمسة من القلق من ٦٦.١ ٪ إلى ٤٥.١ ٪، وأن متوسط القلق الفردي انخفض من مستوى متوسط إلى مستوى خفيف بعد

التدخلات. كما ارتفع متوسط الدعم الاجتماعي المدرك من ٢٦.٨٧ إلى ٣٢.٣٩ بعد هذه الأنشطة، ووصت الدراسة بأن المؤسسات التعليمية ينبغي أن تطبق أنشطة دعم اجتماعي منظّمة، مثل الأندية والجلسات النفسية الجماعية، لتعزيز الشعور بالدعم بين الطلاب والتقليل من مظاهر القلق المزمن بينهم.

ثانياً دراسات تشير إلى العلاقة بين الدعم الاجتماعي و الاكتئاب:

هدفت دراسة (Li & et al.,2015) إلى فحص الدور الوسيط الذي تلعبه المرونة النفسية في العلاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى كبار السن من أصل صيني المقيمين في سنغافورة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام تصميم مقطعي، واشتملت العينة على 162 من كبار السن المقيمين في المجتمع، حيث تم جمع البيانات من خلال مقاييس معيارية لقياس مستويات الدعم الاجتماعي، والمرونة النفسية، وأعراض الاكتئاب. توصلت النتائج إلى أن المرونة النفسية تُسهم بدور وسيط مهم بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب، إذ تبين أن ارتفاع مستوى الدعم الاجتماعي يؤدي إلى تعزيز المرونة النفسية، مما ينعكس في انخفاض مستويات الاكتئاب لدى كبار السن. كما أشارت النتائج إلى أن بعدي المرونة النفسية (حل المشكلات وتنظيم الانفعالات) يعملان بطريقة مقاربة في تفسير هذا التأثير الوسيط.

هدفت دراسة (الزعيبي و آخرون، ٢٠١٩) إلى كشف طبيعة علاقة الدعم الاجتماعي بالاكتئاب لدى طلبة جامعة دمشق، وتحديد مستوى الدعم الاجتماعي المدرك لديهم، كما حاول الباحث الكشف عن طبيعة الفروق بين الذكور والإناث في كل من الدعم الاجتماعي المدرك والاكتئاب. تكونت عينة البحث من (٢٩٧) طالباً وطالبة من طلاب السنة الأولى في جامعة دمشق، كان عدد الذكور فيها (١٤٩) طالباً وعدد الإناث (١٤٨) طالبة سحبا بطريقة عشوائية طبقية. وطبق عليهم مقياس الدعم الاجتماعي المدرك ومقياس الاكتئاب، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى: وجود علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة إحصائية بين الدعم الاجتماعي المدرك والاكتئاب لدى أفراد عينة البحث، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة الذكور والإناث في الدعم الاجتماعي المدرك، لصالح الإناث، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة الذكور والإناث في الاكتئاب.

هدفت دراسة (Alsubaie & et al.,2019) إلى استكشاف أثر مصادر الدعم الاجتماعي المختلفة (مثل الأسرة، الأصدقاء، والأشخاص المهمين) على مستويات الاكتئاب وجودة الحياة لدى طلاب الجامعات. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث شملت عينة مكونة من ٤٦١ طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الجامعية. تم استخدام مقياس الدعم الاجتماعي متعدد الأبعاد (MSPSS) لقياس مصادر الدعم، ومقياس الاكتئاب (PHQ-9) لتقدير شدة الأعراض الاكتئابية، بالإضافة إلى مقياس جودة الحياة لمنظمة الصحة العالمية (WHOQOL-BREF) أظهرت النتائج أن نسبة انتشار الأعراض الاكتئابية بين أفراد العينة بلغت نحو ٣٦%، بدرجات متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة، وأن ارتفاع مستويات الدعم الاجتماعي من الأسرة والأصدقاء ارتبط بانخفاض حدة الاكتئاب وتحسن ملحوظ في جودة الحياة النفسية والاجتماعية.

هدفت دراسة (Li & et al.,2023) إلى فهم التأثير الوقائي للدعم الاجتماعي على الأعراض الاكتئابية من منظور شبكي طولي، وذلك من خلال تحليل العلاقات الديناميكية بين الدعم الاجتماعي وأعراض الاكتئاب عبر الزمن. كما سعت إلى استكشاف الدور الوسيط للشعور بالوحدة في هذه العلاقة، وتحديد الفروق بين الجنسين في كيفية تأثير الدعم الاجتماعي على مظاهر الاكتئاب. اعتمدت الدراسة تصميمًا طوليًا مستخدمة نموذج شبكة الأعراض الديناميكية عبر الزمن لتحليل كيف يؤثر الدعم الاجتماعي على الأعراض الاكتئابية بمرور الوقت، استخدمت بيانات من موجتين من مسح الصحة النفسية الدولي الخاصة بمرض (كوفيد-19) بين مايو وأكتوبر ٢٠٢٠، بلغ عدد المشاركين ٤٢٤٢ شخصًا بالغًا أكملوا موقعي المسح من الموجة الأولى والثانية، و قد توصلت الدراسة إلى أن الدعم الاجتماعي له تأثير وقائي أحادي الاتجاه على بعض أعراض الاكتئاب، خاصة أعراض فقدان المتعة والتقييم الذاتي السلبي و كذلك أشارت الدراسة أن الشعور بالوحدة يعمل كوسيط جزئي بين الدعم الاجتماعي وأعراض الاكتئاب؛ فالدعم الاجتماعي يقلل من الشعور بالوحدة، والذي بدوره يرتبط بانخفاض في المزاج المكتئب والتقييم الذاتي السلبي، كما لوحظت فروقات بين الجنسين: فعلاقات الدعم الاجتماعي بالاكتئاب كانت أقوى لدى الرجال مقارنة بالنساء.

هدفت دراسة (Yu & et al.,2023) إلى فحص تأثير الدعم الاجتماعي على الاكتئاب لدى طلبة جامعيين ذوي وضع اقتصادي محدود، مع التحقق من دور المرونة النفسية كوسيط، والجغرافيا كمُعدّل للعلاقة، اعتمدت المنهجية على تصميم مقطعي، حيث استخدمت استبانات معيارية لقياس الدعم الاجتماعي، والمرونة النفسية، والاكتئاب، ووُزعت على عينة مؤلفة من ٤٢٤ طالبًا جامعيًا ذوي دخل اقتصادي محدود في مقاطعتين؛ إحداهما ساحلية (X) والأخرى داخلية (Y)، أظهرت النتائج أن الدعم الاجتماعي يرتبط إيجابيًا بالمرونة النفسية ($\beta = 0.62$)، وأن المرونة النفسية ترتبط سلبًا بالاكتئاب ($\beta = -0.24$)، كما أن الدعم الاجتماعي يرتبط سلبًا بالاكتئاب مباشرة ($\beta = -0.08$). وُجد أن المرونة النفسية تلعب دورًا وسيطًا جزئيًا بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب. أما الجغرافيا فتبين أنها تُعدّل العلاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب، حيث كانت العلاقة أقوى (سالبة) في المقاطعة الساحلية من المقاطعة الداخلية.

هدفت دراسة (Ersoy & et al.,2025) إلى استقصاء العلاقة التفاعلية بين الدعم الاجتماعي والضغط الناتجة عن التكيف الثقافي والإجهاد المدرك والقلق العام لدى الطلاب الدوليين، تمت الدراسة على عينة من 190 طالبًا دوليًا من جامعة كاستامونو، من بينهم ٨٤ طالبة و١٠٥ طلاب، وكان متوسط عمرهم حوالي 20.87 سنة مع انحراف معياري 2.79 تم استخدام عدة مقاييس معيارية: مقياس الضغط الناتجة عن الاندماج الثقافي، مقياس الضغط المدركة، مقياس الدعم الاجتماعي، مقياس اضطراب القلق العام (GAD-7)، أظهرت النتائج أن الضغط الناتجة عن الاندماج الثقافي والضغط المدركة يُساهمان بشكل مستقل في ارتفاع مستويات القلق العام بين الطلاب الدوليين،

بينما لم يكن للدعم الاجتماعي تأثير قوي أو مباشر في التخفيف من القلق العام عبر المسارات المعتادة، أي أن العلاقة بين الدعم الاجتماعي وبعض الضغط لم تكن ذات دلالة قوية في نماذج الانحدار المستخدمة كما تبين أن الضغط المدركة تعمل كوسيط جزئي بين الضغط الثقافية، والقلق العام، مما يعني أن تجربة الضغط تُعزز من القلق إلى حد ما من خلال كيف يدركها الطالب.

التعقيب على الدراسات السابقة:

يتضح من الدراسات السابقة والتي تم عرضها أنها جميعها تدور حول الكشف عن طبيعة العلاقة بين كل من الدعم الاجتماعي و القلق، و كذلك لدعم الاجتماعي و الاكتئاب و هناك أوجه تشابه و أوجه اختلاف مع الدراسة الحالية متمثلة فيما يلي:

تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة كل من (Peter & et al.,2017)، (محمد، ٢٠٢٢)، (جريفي، ٢٠٢٣)، (Zhang & He,2025)، (Yang & et)، al.,2025 في دراسة العلاقة بين الدعم الاجتماعي واضطرابات القلق.

كما تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة كل من (Li & et al.,2015)، ودراسة (الزعيبي و آخرون، ٢٠١٩)، و دراسة (Alsubaie & et al.,2019)، و دراسة (Li & et al.,2023)، و دراسة (Yu & et al.,2023)، و دراسة (Ersoy & et al.,2025).

و تمثلت أوجه الاختلاف في أن شملت عينة الدراسة الحالية على العاملين بالقطاعات الطبي و الإداري بمستشفى النور بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بينما جاءت دراسة (Peter & et al.,2017) لتشمل على عينة من المراهقات الحوامل، و جاءت دراسة (محمد، ٢٠٢٢) لتشمل على عينة تتمثل في لدى أمهات أطفال الروضة، بينما شملت دراسة (جريفي، ٢٠٢٣) على عينة متمثلة في أمهات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، و جاءت دراسة (Zhang & He,2025) متمثلة في عينة من طلاب الجامعات الصينيين، كما جاءت دراسة (Yang & et al.,2025) لدى طلاب الجامعات، وجاءت دراسة (Li & et al.,2015) لتشمل على عينة دراسة متمثلة في كبار السن، و تمثلت عينة دراسة (الزعيبي و آخرون، ٢٠١٩) في طلبة جامعة دمشق، و جاءت دراسة (Alsubaie & et al.,2019) متمثلة في طلاب الجامعات، و تمثلت عينة دراسة (Li & et al.,2023) في عدد من المتعافين من مرض كوفيد ١٩، و عينة دراسة (Yu & e al.,2023) تمثلت في طلبة جامعيين ذوي وضع اقتصادي محدود، و جاءت دراسة (Ersoy & et al.,2025) في عينة من طلاب الجامعات.

- فرضيات الدراسة:

١. توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بالمستشفيات.
٢. توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات.
٣. يوجد تباين في كل من متوسطات الدعم الاجتماعي و القلق و الاكتئاب باختلاف (الجنس، العمر، الوظيفة، سنوات الخبرة).

الجانب الميداني للدراسة:

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي الارتباطي، نظرًا لملاءمته لطبيعة أهداف البحث التي تسعى إلى التعرف على العلاقة بين الدعم الاجتماعي وبعض الاضطرابات النفسية (كالقلق والاكتئاب) لدى العاملين بالمستشفيات، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانة مكون من مجموعة من المقاييس التي تقيس متغيرات الدراسة، وذلك بغرض التعرف على مستوى الدعم الاجتماعي والاضطرابات النفسية لدى أفراد العينة، والكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية فيما بينها.

حدود الدراسة:

تمثلت الحدود للدراسة فيما يلي:

١. الحدود الموضوعية: التعرف على الدعم الاجتماعي وعلاقته ببعض الاضطرابات النفسية لدى العاملين بالمستشفيات.
٢. الحدود البشرية: تتمثل في عينة من العاملين في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
٣. الحدود المكانية: تم تطبيقها في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

4. الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة في العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

مجتمع و عينة الدراسة:

تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة مكونة من ١٦٨ مفردة من العاملين بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي

والإداري من مجتمع مكون من ٣٠٠ مفردة من العاملين، باختلاف الخصائص الديموغرافية من حيث (الجنس، العمر، الوظيفة، سنوات الخبرة).
قام الباحث على عينة استطلاعية مكونة من ٣٠ مفردة للتأكد من ثبات و صدق الاستبانة.

خصائص عينة الدراسة:

فيما يلي يتم توضيح خصائص عينة الدراسة بالنسبة للبيانات الديموغرافية (الجنس، السن، التخصص، سنوات الخبرة):

جدول (1) يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للبيانات الديموغرافية

التصنيف	العدد	النسبة
الجنس	ذكر	٩٦
	أنثى	٧٢
	الإجمالي	١٦٨
السن	أقل من ٣٠ سنة	٨٠
	من ٣٠ سنة إلى ٤٠ سنة	٥٦
	من ٤١ سنة إلى ٥٠ سنة	٢٤
	٥١ سنة فما فوق	٨
	الإجمالي	١٦٨
	الطبي	١٠٦
التخصص	الإداري	٦٢
	الإجمالي	١٦٨
	الطبي	١٠٦
سنوات الخبرة	٥ سنوات أو أقل	٨٦
	من ٦ سنوات إلى ١٠ سنوات	٦٨
	من ١١ سنة فما فوق	١٤
	الإجمالي	١٦٨

الجدول السابق يوضح توزيع عينة الدراسة التي بلغت (١٦٨) فرداً من العاملين في مستشفى النور بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي والإداري، تبعاً للبيانات الديموغرافية والتي جاءت كالتالي:

- بالنسبة لمتغير الجنس: بلغ عدد الذكور (٩٦) ذكر بنسبة (٥٧.١%)، في حين بلغ عدد الإناث (٧٢) أنثى بنسبة (٤٢.٩%)، وهذا يشير إلى أن غالبية أفراد العينة من الذكور.
- بالنسبة لمتغير العمر: تبين أن (٨٠) فردًا من أفراد العينة أعمارهم أقل من (٣٠) سنة بنسبة (٤٧.٦%)، و(٥٦) فردًا تتراوح أعمارهم ما بين (٣٠-٤٠) سنة بنسبة (٣٣.٣%)، و(٢٤) فردًا تتراوح أعمارهم بين (٤١-٥٠) سنة بنسبة (١٤.٣%)، بينما بلغ عدد الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن (٥١) سنة فأكثر (٨) أفراد بنسبة (٤.٨%)، مما يدل على أن غالبية المشاركين من فئة الشباب.
- بالنسبة لمتغير التخصص: بلغ عدد العاملين في القطاع الطبي (١٠٦) فردًا بنسبة (٦٣.١%)، في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الإداري (٦٢) فردًا بنسبة (٣٦.٩%)، وهو ما يعكس أن معظم العينة من العاملين في القطاع الطبي.
- بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة: تبين أن (٨٦) فردًا لديهم خبرة (٥ سنوات أو أقل) بنسبة (٥١.٢%)، و(٦٨) فردًا خبرتهم تتراوح ما بين (٦-١٠ سنوات) بنسبة (٤٠.٥%)، في حين بلغ عدد الأفراد ذوي الخبرة (١١ سنة فأكثر) (١٤) فردًا بنسبة (٨.٣%)، مما يشير إلى أن أغلب المشاركين من الأشخاص الذين لديهم سنوات خبرة من ٥ سنوات فأقل.

أدوات الدراسة:

قام الباحث بالاطلاع على التراث البحثي على بعض مقاييس أبعاد الدعم الاجتماعي ومنها:

مقياس (Minjeong et al., 2025)، (Hyewon et al., 2024)، (zimet al., 1988)، (Minjeong et al., 2025).

قام الباحث بالإطلاع على التراث البحثي على بعض مقاييس أبعاد القلق ومنها: مقياس سبيلبرجر للقلق (حالة وسمة) ، لمقياس اضطراب القلق المعمم (GAD) ، و مقياس تايلور للقلق الصريح. (TMAS)

قام الباحث بالإطلاع على التراث البحثي على بعض مقاييس أبعاد الاكتئاب ومنها: مقياس هاملتون لتقييم الاكتئاب (HRSD)، و مقياس بيك للاكتئاب (Beck)

Depression Inventory

و قام الباحث بإعداد:

١. استمارة البيانات الأولية للعاملين.

٢. استبانة الدعم الاجتماعي للعاملين.

٣. استبانة لمقياس القلق للعاملين.

٤. استبانة لمقياس الاكتئاب للعاملين.

تتمثل أداة الدراسة في الاستبانة المتكونة من:

المحور الأول (الدعم الاجتماعي): يتكون من ١٨ عبارة موزعة على ٣ أبعاد (الدعم المعلوماتي، الدعم العاطفي، الدعم المهني) لكل بُعد ٦ عبارات.

المحور الثاني (القلق): يتكون من ١٨ عبارة موزعة على ٣ أبعاد (الأعراض السلوكية، الأعراض الجسدية، الأعراض المعرفية) لكل بُعد ٦ عبارات.

المحور الثالث (الاكتئاب): يتكون من ١٨ عبارة موزعة على ٣ أبعاد (الأعراض الاجتماعية، الأعراض الانفعالية، الأعراض الجسمية) لكل بُعد ٦ عبارات.

اتبع الباحث سلم تدرج خماسي الترتيب في تصميم مقياس الدعم الاجتماعي للعاملين.

و تم اعتماد السلم الخماسي لمناسبته لطبيعة البحث الحالي، و بناء على مشورة بعض المختصين و ذوي الخبرة في هذا المجال تم تصحيح المقياس على النحو التالي:

تعكس تلك التقديرات: موافق تماماً (٥ درجات)، موافق (٤ درجات)، محايد (٣ درجات)، غير موافق (درجتين)، غير موافق تماماً (درجة واحدة) .

اتبع الباحث سلم تدرج خماسي الترتيب في تصميم مقياس القلق للعاملين.

و تم اعتماد السلم الخماسي لمناسبته لطبيعة البحث الحالي، و بناء على مشورة بعض المختصين و ذوي الخبرة في هذا المجال تم تصحيح المقياس على النحو التالي:

تعكس تلك التقديرات: موافق تماماً (٥ درجات)، موافق (٤ درجات)، محايد (٣ درجات)، غير موافق (درجتين)، غير موافق تماماً (درجة واحدة) .

اتبع الباحث سلم تدرج خماسي الترتيب في تصميم مقياس الاكتئاب للعاملين. و تم اعتماد السلم الخماسي لمناسبته لطبيعة البحث الحالي، و بناء على مشورة بعض المختصين و ذوي الخبرة في هذا المجال تم تصحيح المقياس على النحو التالي:

تعكس تلك التقديرات: موافق تماماً (٥ درجات)، موافق (٤ درجات)، محايد (٣ درجات)، غير موافق (درجتين)، غير موافق تماماً (درجة واحدة) .

نتائج الدراسة الاستطلاعية:

الاتساق الداخلي:

تم التحقق من الاتساق الداخلي للاستبانة من خلال تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من ٣٠ مفردة، وحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات المحاور الثلاثة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي عليه الفقرة، وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS V.26 والجداول التالية توضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور .

أولاً الدعم الاجتماعي:

١ - صدق الاتساق الداخلي للبعد الأول (الدعم المعلوماتي).

جدول (2) صدق الاتساق الداخلي للبعد الأول (الدعم المعلوماتي).

البعد الأول (الدعم المعلوماتي)	معامل ارتباط عبارات بُعد (الدعم المعلوماتي) بالدرجة الكلية للبعد	الدلالة
١- أستطيع الحصول على المعلومات اللازمة لأداء وظيفتي بفعالية	٠.٥٢١**	٠.٠٠٠
٢- أجد أن المعلومات التي أحصل عليها دقيقة وموثوقة	٠.٦٥٣**	٠.٠٠٠
٣- أجد أن المعلومات التي أحصل عليها تستغرق وقتاً طويلاً	٠.٥٣٣**	٠.٠٠٠
٤- تساعدني المعلومات التي أحصل عليها في اتخاذ القرارات الصحيحة	٠.٧٤٩**	٠.٠٠٠
٥- يسبب لي الدعم المعلوماتي إحباطاً وتوتراً	٠.٨١٧**	٠.٠٠٠
٦- يزيد الدعم المعلوماتي من كفاءتي في العمل	٠.٥١٩**	٠.٠٠٠
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط ليبرسون بين فقرات البعد الأول (الدعم المعلوماتي) والدرجة الكلية للبعد الأول معنوية ودالة، عند مستوى معنوية ٠.٠٠١، كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط 0.519، بينما كان الحد الأعلى هو 0.817

٢ - صدق الاتساق الداخلي للبعد الثاني (الدعم العاطفي).

جدول (3) صدق الاتساق الداخلي للبعد الثاني (الدعم العاطفي).

البعد الثاني (الدعم العاطفي)	معامل ارتباط عبارات بُعد (الدعم العاطفي) بالدرجة الكلية للبعد	الدلالة
٧- أشعر بالدعم والمحبة من زملائي في العمل	٠.٤٨٨**	٠.٠٠٠
٨- يوفر لي مديري في العمل الدعم العاطفي اللازم	٠.٧٠٦**	٠.٠٠٠
٩- أشعر بالحزن بسبب نقص الدعم العاطفي	٠.٧١٤**	٠.٠٠٠
١٠- تدعم بيئة العمل في المستشفى صحتي النفسية	٠.٧٥٠**	٠.٠٠٠
١١- أشعر بالوحدة والانفصال عن زملائي في العمل	٠.٧٣٠**	٠.٠٠٠
١٢- أشعر بالراحة عندما أتحدث عن مشاكلي مع زملائي في العمل	٠.٧١٥**	٠.٠٠٠
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط لبيرسون بين فقرات البعد الثاني (الدعم العاطفي) والدرجة الكلية للبعد الثاني معنوية ودالة، وذلك عند مستوى معنوية ٠.٠١ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط ٠.٤٨٨، بينما كان الحد الأعلى هو ٠.٧٥٠.

٣- صدق الاتساق الداخلي للبعد الثالث (الدعم المهني).

جدول (4) صدق الاتساق الداخلي للبعد الثالث (الدعم المهني).

البعد الثالث (الدعم المهني)	معامل ارتباط عبارات بُد (الدعم المهني) بالدرجة الكلية للبعد	الدلالة
١٣- يوفر لي زملائي في العمل المساعدة والخبرة المناسبة	٠.٧٣٠**	٠.٠٠٠
١٤- يمكنني الحصول على التدريب والتنمية اللازمة لتحسين مهاراتي	٠.٥٩٣**	٠.٠٠٠
١٥- يزيد الدعم المهني من ثقتي بنفسي وقدراتي	٠.٦٨١**	٠.٠٠٠
١٦- يساعدني الدعم المهني على تحقيق أهدافي المهنية	٠.٦٣٩**	٠.٠٠٠
١٧- أشعر بالدعم والتقدير من زملائي ومديري	٠.٧٠٨**	٠.٠٠٠
١٨- أشعر بالقلق على مستقبلي المهني	٠.٥٠٥**	٠.٠٠٠
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط لبيرسون بين فقرات البعد الثالث (الدعم العاطفي) والدرجة الكلية للبعد الثالث معنوية ودالة، عند مستوى معنوية ٠.٠١ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط ٠.٥٠٥، بينما كان الحد الأعلى هو ٠.٧٣٠.

ثانياً القلق:

١ - صدق الاتساق الداخلي للبعد الأول (الأعراض السلوكية).

جدول (5) صدق الاتساق الداخلي للبعد الأول (الأعراض السلوكية).

البعد الأول (الأعراض السلوكية)	معامل ارتباط عبارات بُد (الأعراض السلوكية) بالدرجة الكلية للبعد	الدلالة
١٩- أشعر بالقلق دون مبرر.	٠.٨٠٩**	٠.٠٠٠
٢٠- ينتابني شعور بالعصبية في كثير من المواقف ولا أستطيع التغلب عليه.	٠.٧٦٦**	٠.٠٠٠
٢١- أشعر بالتوتر عند التحدث مع الآخرين.	٠.٦٥٤**	٠.٠٠٠

(الدعم الاجتماعي وعلاقته ببعض الاضطرابات النفسية...) أ. صلاح مستور عايش الثبتي وآخرون

٠.٠٠٠	٠.٦٢٢**	٢٢-أنا حساس أكثر من الآخرين.
٠.٠٠٠	٠.٧٠٥**	٢٣-أنا قليل الكلام في المواقف الاجتماعية.
٠.٠٠٠	٠.٦٨٩**	٢٤-أنا كثير بالاحداث.
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط لبيرسون بين فقرات البعد الأول (الأعراض السلوكية) والدرجة الكلية للبعد الأول معنوية ودالة، وذلك عند مستوى معنوية ٠.٠٠١ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط ٠.٦٢٢، بينما كان الحد الأعلى هو ٠.٨٠٩

٢- صدق الاتساق الداخلي للبعد الثاني (الأعراض الجسدية).

جدول (6) صدق الاتساق الداخلي للبعد الثاني (الأعراض الجسدية).

البعد الثاني (الأعراض الجسدية)	معامل ارتباط عبارات بُعد (الأعراض الجسدية) بالدرجة الكلية للبعد	الدالة
٢٥-تصبيني نوبات من الغثيان.	٠.٨١٧**	٠.٠٠٠
٢٦-أشعر بالتعب بسرعة.	٠.٧٦٤**	٠.٠٠٠
٢٧-أعرق كثيرا حتى في الأيام الباردة.	٠.٨٨٤**	٠.٠٠٠
٢٨-كثيرا ما أشعر أن قلبي يخفق بسرعة.	٠.٧٧٨**	٠.٠٠٠
٢٩-أعاني كثيرا من الصداع.	٠.٧٨٨**	٠.٠٠٠
٣٠-نومي مضطرب ومتقطع.	٠.٧٥٢**	٠.٠٠٠
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط لبيرسون بين فقرات البعد الثاني (الأعراض الجسدية) والدرجة الكلية للبعد الثاني معنوية ودالة، وذلك عند مستوى معنوية ٠.٠٠١ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط ٠.٧٥٢، بينما كان الحد الأعلى هو ٠.٨٨٤

٣- صدق الاتساق الداخلي للبعد الثالث (الأعراض المعرفية).

جدول (7) صدق الاتساق الداخلي للبعد الثالث (الأعراض المعرفية).

البعد الثالث (الأعراض المعرفية)	معامل ارتباط عبارات بُعد (الأعراض المعرفية) بالدرجة الكلية للبعد	الدلالة
٣١- دائما ينتابني شعور بالقلق من أشياء غامضة.	٠.٨٢٥**	٠.٠٠٠
٣٢- أخشى التعبير عن نفسي.	٠.٧٩٩**	٠.٠٠٠
٣٣- تنثير قلقي أمور المال والعمل.	٠.٧٤٨**	٠.٠٠٠
٣٤- أخشى الظهور بشكل غير ملائم.	٠.٧٩١**	٠.٠٠٠
٣٥- يمر على أيام لا أنام بسبب القلق.	٠.٧٥٨**	٠.٠٠٠
٣٦- أكون حريص على الالتزام بالتعليمات خوفا من الانتقاد.	٠.٧٤٩**	٠.٠٠٠
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط لبيرسون بين فقرات البعد الثالث (الأعراض المعرفية) والدرجة الكلية للبعد الثالث معنوية ودالة، وذلك عند مستوى معنوية ٠.٠١ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط 0.749، بينما كان الحد الأعلى هو 0.825
ثالثاً الاكتئاب:

١- صدق الاتساق الداخلي للبعد الأول (الأعراض الاجتماعية).

جدول (8) صدق الاتساق الداخلي للبعد الأول (الأعراض الاجتماعية).

البعد الأول (الأعراض الاجتماعية)	معامل ارتباط عبارات بُعد (الأعراض الاجتماعية) بالدرجة الكلية للبعد	الدلالة
٣٧- فقدت اهتمامي بممارسة أنشطتي وهواياتي المعتادة.	٠.٨٠١**	٠.٠٠٠
٣٨- أتجنب حضور الأنشطة واللقاءات الاجتماعية.	٠.٧٦٥**	٠.٠٠٠
٣٩- يلزمني شعور بالانزعاج والوحدة.	٠.٨١٥**	٠.٠٠٠
٤٠- أفضل البقاء وحيداً في البيت معظم الوقت.	٠.٨٤٤**	٠.٠٠٠
٤١- أشعر بنفور الآخرين أو ابتعادهم عني.	٠.٧٩٩**	٠.٠٠٠
٤٢- لا أستطيع مشاركة أصدقائي بما يزعجني.	٠.٧٧٩**	٠.٠٠٠
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط لبيرسون بين فقرات البعد الأول (الأعراض الاجتماعية) والدرجة الكلية للبعد الأول معنوية ودالة، وذلك عند مستوى معنوية ٠.٠١ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط 0.765، بينما كان الحد الأعلى هو 0.844

٢- صدق الاتساق الداخلي للبعد الثاني (الأعراض الانفعالية).

جدول (9) صدق الاتساق الداخلي للبعد الثاني (الأعراض الانفعالية).

البعد الثاني (الأعراض الانفعالية)	معامل ارتباط عبارات بُعد (الأعراض الانفعالية) بالدرجة الكلية للبعد	الدلالة
٤٣- أشعر بالحزن معظم الوقت ولا أستطيع التخلص منه.	٠.٨٥٩**	٠.٠٠٠
٤٤- أشعر بأن لديّ مستقبلًا أقل إشراقًا.	٠.٨٣١**	٠.٠٠٠
٤٥- أشعر بالذنب معظم الوقت.	٠.٨٠٧**	٠.٠٠٠
٤٦- أشعر بأنني عديم القيمة تمامًا.	٠.٧٣١**	٠.٠٠٠
٤٧- ألوم نفسي أكثر من المعتاد.	٠.٨٣٧**	٠.٠٠٠
٤٨- أشعر أنني فاشل معظم الوقت.	٠.٧٤٦**	٠.٠٠٠
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط لبيرسون بين فقرات البعد الثاني (الأعراض الانفعالية) والدرجة الكلية للبعد الثاني معنوية ودالة، وذلك عند مستوى معنوية ٠.٠١ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط ٠.٧٣١، بينما كان الحد الأعلى هو ٠.٨٥٩

٣- صدق الاتساق الداخلي للبعد الثالث (الأعراض الجسمية).

جدول (10) صدق الاتساق الداخلي للبعد الثالث (الأعراض الجسمية).

البعد الثالث (الأعراض الجسمية)	معامل ارتباط عبارات بُعد (الأعراض الجسمية) بالدرجة الكلية للبعد	الدلالة
٤٩- أبدأ في النوم بصعوبة أو أستيقظ قبل الوقت المعتاد	٠.٨٦٢**	٠.٠٠٠
٥٠- فقدت الاهتمام بمعظم الأنشطة.	٠.٨٤٨**	٠.٠٠٠
٥١- أشعر بالتعب عند القيام بأي عمل.	٠.٨٦٣**	٠.٠٠٠
٥٢- لا أستمتع بمعظم الأشياء التي كنت أستمتع بها.	٠.٨٥٢**	٠.٠٠٠

٥٣-أشعر بالصداع بدون سبب.	٠.٧٩٠**	٠.٠٠٠
٥٤-أفقد شهيتي كثيرًا.	٠.٨٢٥**	٠.٠٠٠
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

من خلال الجدول السابق نجد أن جميع معاملات الارتباط ليبرسون بين فقرات البعد الثالث (الأعراض الجسمية) والدرجة الكلية للبعد الثالث معنوية ودالة، وذلك عند مستوى معنوية ٠.٠١ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط 0.790، بينما كان الحد الأعلى هو 0.863

ثانياً ثبات الاستبيان ككل ومحاوره:

تم التحقق من مدى ثبات أداة الدراسة (الاستبانة) من خلال استخدام (معاملات ألفا كرونباخ) للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة استطلاعية مكونة من ٣٠ مفردة (وقد تم استبعادها من العينة الكلية)، والجدول التالي يوضح معاملات ثبات أداة الدراسة.

جدول (11) معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

المحور	معامل الثبات	عدد العبارات
الدعم الاجتماعي	٠.٨٤٣	١٨
القلق	٠.٨٤٨	١٨
الاكتئاب	٠.٩٦٠	١٨
الاستبيان ككل	٠.٩٤٣	٥٤

يوضح الجدول السابق قيم معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) للاستبيان ومحاوره، والتي تراوحت بين (٠.٨٤٣ - ٠.٩٦٠)، وهي تشير على مستويات عالية من الثبات، حيث تجاوزت جميع القيم الحد المقبول إحصائياً (٠.٧)، وهذا يعكس صلاحية الأداة في الاستخدام لعينة البحث الحالي.

وفيما يلي عرض ثبات كل محور بأبعاده على حدة:

أولاً الدعم الاجتماعي:

جدول (12) معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحور الدعم الاجتماعي

محور (الدعم الاجتماعي)	معامل الثبات	عدد العبارات
الدعم المعلوماتي	٠.٧١٤	٦
الدعم العاطفي	٠.٧٧٧	٦
الدعم المهني	٠.٧١٥	٦
المحور ككل	٠.٨٤٣	١٨

(الدعم الاجتماعي وعلاقته ببعض الاضطرابات النفسية...) أ. صلاح مستور عايش الثبتي وآخرون

يوضح الجدول السابق قيم معاملات الثبات لمحور (الدعم الاجتماعي) بأبعاده، والتي تراوحت بين (٠.٧١٤ - ٠.٨٤٣)، وهي تشير على مستويات عالية من الثبات، حيث تجاوزت جميع القيم الحد المقبول إحصائياً (٠.٧)، وهذا يعكس صلاحية هذا المحور بأبعاده في الاستخدام لعينة البحث الحالي.

ثانياً القلق:

جدول (13) معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحور القلق

محور (القلق)	معامل الثبات	عدد العبارات
الأعراض السلوكية	٠.٧٩٩	٦
الأعراض الجسدية	٠.٨٨٢	٦
الأعراض المعرفية	٠.٨٧٦	٦
المحور ككل	٠.٨٤٨	١٨

يوضح الجدول السابق قيم معاملات الثبات لمحور (القلق) بأبعاده، والتي تراوحت بين (٠.٧٩٩ - ٠.٨٨٢)، وهي تشير على مستويات عالية من الثبات، حيث تجاوزت جميع القيم الحد المقبول إحصائياً (٠.٧)، وهذا يعكس صلاحية هذا المحور بأبعاده في الاستخدام لعينة البحث الحالي.

ثالثاً الاكتئاب:

جدول (١٣) معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحور الاكتئاب

محور (الاكتئاب)	معامل الثبات	عدد العبارات
الأعراض الاجتماعية	٠.٨٨٥	٦
الأعراض الانفعالية	٠.٨٨٧	٦
الأعراض الجسمية	٠.٩١٥	٦
المحور ككل	٠.٩٦٠	١٨

يوضح الجدول السابق قيم معاملات الثبات لمحور (القلق) بأبعاده، والتي تراوحت بين (٠.٨٨٥ - ٠.٩٦٠)، وهي تشير على مستويات عالية من الثبات، حيث تجاوزت جميع القيم الحد المقبول إحصائياً (٠.٧)، وهذا يعكس صلاحية هذا المحور بأبعاده في الاستخدام لعينة البحث الحالي.

بشكل عام نستنتج أن الاستبانة يتمتع بصدق وثبات جيد وهذا يدل على صلاحية أداة الاستبانة في التطبيق بالنسبة للبحث الحالي.

عرض نتائج الدراسة:

الإحصاءات الوصفية لعينة الدراسة:

جدول (14) الإحصاء الوصفي لبيانات عينة الدراسة (ن=١٦٨)

المتغير	المتوسط	الوسيط	الانحراف المعياري
الدعم الاجتماعي	٤.٢٥٩	٤.٣٣٣	٠.٣٠٨
القلق	٢.٤٦٨	٢.٤٤٤	٠.٢٨٣
الاكتئاب	١.٧٥٦	١.٧٢٢	٠.٤٧٩

يوضح الجدول السابق القيم الإحصائية الوصفية لمتغيرات الدراسة (الدعم الاجتماعي،

القلق، الاكتئاب) لعينة الدراسة وعددها (168)، التي جاءت كالتالي:

- المتوسط الحسابي لمستوى الدعم الاجتماعي بلغ (٤.٢٥٩) وهو مرتفع نسبياً، مما يعكس إدراك المشاركين لوجود مستوى جيد من الدعم الاجتماعي، كما أن قيمة الوسيط (٤.٣٣٣) متقاربة مع المتوسط مما يشير إلى تجانس البيانات.
 - أما متوسط القلق فبلغ (٢.٤٦٨) وهو متوسط يميل للانخفاض، وقيمة الوسيط (٢.٤٤٤) قريبة من المتوسط، ما يعكس عدم وجود تباينات كبيرة بين أفراد العينة.
 - في حين أن متوسط الاكتئاب بلغ (١.٧٥٦) وهو منخفض نسبياً، حيث جاءت قيمة الوسيط (١.٧٢٢) قريبة من المتوسط، مما يدل على أن معظم الأفراد لديهم مستوى منخفض من الاكتئاب.
- بوجه عام تشير النتائج إلى أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى مرتفع من الدعم الاجتماعي يقابله انخفاض في مستويات القلق والاكتئاب.

٣.٧.٥ نتائج فروض الدراسة وتفسيرها:

١. توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بالمستشفيات.
جدول (15) معامل ارتباط بيرسون لتوضيح العلاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بالمستشفيات.

العلاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بالمستشفيات		
معامل الارتباط	مستوى المعنوية	حجم العينة
-0.523**	0.000	168
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

الجدول السابق يوضح العلاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي والإداري، والذي من خلاله نستنتج وجود علاقة ارتباط معنوية سالبة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بالمستشفيات،

حيث بلغ معامل الارتباط (-0.523) عند مستوى معنوية (Sig. = 0.000) وهو أقل من مستوى الدلالة ٠.٠٠١،

وهذا يشير على أنه كلما ارتفع مستوى الدعم الاجتماعي الذي يحصل عليه العاملين، كلما انخفض مستوى القلق لديهم، والعكس صحيح، ويمثل هذا الارتباط قوة متوسطة في الاتجاه السالب، وهذا يعكس الدور الإيجابي الذي يلعبه الدعم الاجتماعي في التخفيف من حدة القلق لدى العاملين بمستشفى النور في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي والإداري.

وبالتالي نقبل فرضية الدراسة التي تنص على أنه توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بالمستشفيات.

٢. توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات.
جدول (16) معامل ارتباط بيرسون لتوضيح العلاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات.

العلاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات		
معامل الارتباط	مستوى المعنوية	حجم العينة
-0.493**	0.000	168
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

الجدول السابق يوضح العلاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي والإداري، والذي من خلاله نستنتج وجود علاقة ارتباط معنوية سالبة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات، حيث بلغ معامل الارتباط (-0.493) عند مستوى معنوية (Sig. = 0.000) وهو أقل من مستوى الدلالة 0.001، وهذا يشير على أنه كلما ارتفع مستوى الدعم الاجتماعي الذي يحصل عليه العاملين، كلما انخفض مستوى الاكتئاب لديهم، والعكس صحيح، ويمثل هذا الارتباط قوة متوسطة في الاتجاه السالب، وهذا يعكس الدور الوقائي للدعم الاجتماعي في التخفيف من أعراض الاكتئاب وتعزيز الصحة النفسية لدى العاملين بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي والإداري. وبالتالي نقبل فرضية الدراسة التي تنص على أنه توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات.

٣. يوجد تباين في كل من متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب باختلاف (الجنس، العمر، الوظيفة، سنوات الخبرة).

أولاً بالنسبة للجنس:

جدول (17) اختبار T لعينتين مستقلتين (Independent Samples T-Test) لتوضيح التباين في متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب بالنسبة لمتغير الجنس.

النوع	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة t	درجات الحرية (df)	مستوى المعنوية (Sig)	مستوى الدلالة
الـدعم الاجتماعي	ذكر	4.287	1.381	166	0.169	غير دالة إحصائياً
	أنثى	4.222				
القلق	ذكر	2.457	-0.586	166	0.559	غير دالة إحصائياً
	أنثى	2.483				
الاكتئاب	ذكر	1.741	-0.456	166	0.649	غير دالة إحصائياً
	أنثى	1.775				

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث العاملين بمستشفى النور في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي والإداري في كل من الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب، حيث جاءت قيم الدلالة (Sig.) لكل المتغيرات أكبر من مستوى الدلالة (٠.٠٥)، حيث بلغ متوسط الدعم الاجتماعي لدى الذكور (٤.٢٨٧) مقابل (٤.٢٢٢) لدى الإناث،

إلا أن الفروق لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائي (Sig= 0.169) كما بلغ متوسط القلق لدى الذكور (٢.٤٥٧) مقابل (٢.٤٨٣) لدى الإناث، والفروق كذلك لم تكن معنوية (Sig = 0.559) وبالمثل بلغ متوسط الاكتئاب لدى الذكور (١.٧٤١) مقابل (١.٧٧٥) لدى الإناث، والفروق أيضاً لم تصل إلى مستوى الدلالة (Sig. = 0.649).

وبالتالي نستنتج أن متغير الجنس ليس له تأثير معنوي على مستويات الدعم الاجتماعي أو القلق أو الاكتئاب لدى أفراد العينة، وبالتالي نرفض فرضية الدراسة التي تنص على

أنه يوجد تباين في كل من متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب باختلاف الجنس.

وبالتالي نستنتج أنه لا يوجد تباين في متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب باختلاف الجنس.

ثانياً بالنسبة للعمر:

جدول (18) تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لتوضيح التباين في متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب بالنسبة لمتغير العمر

تحليل التباين						
مستوى المعنوية Sig.	قيمة (ف) F	متوسط المربعات	درجات الحرية df	مجموع المربعات		
٠.٢٨١	١.٢٨٦	٠.١٢٢	٣	٠.٣٦٥	بين المجموعات	الدعم الاجتماعي
		٠.٠٩٥	١٦٤	١٥.٥٠٣	داخل المجموعات	
			١٦٧	١٥.٨٦٨	الإجمالي	
٠.١٢٠	١.٩٧٤	٠.١٥٥	٣	٠.٤٦٥	بين المجموعات	القلق
		٠.٠٧٨	١٦٤	١٢.٨٦٦	داخل المجموعات	
			١٦٧	١٣.٣٣١	الإجمالي	
٠.١٧٢	١.٦٨٨	٠.٣٨٣	٣	١.١٤٩	بين المجموعات	الاكتئاب
		٠.٢٧٧	١٦٤	٣٧.٢١٥	داخل المجموعات	
			١٦٧	٣٨.٣٦٤	الإجمالي	

يبين الجدول السابق نتائج تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لاختبار الفرض المتعلق بمتغير العمر لدى العاملين بمستشفى النور في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي والإداري، حيث أظهرت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات العمرية المختلفة في كل من الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب، حيث بلغت قيمة (F) لمتغير الدعم الاجتماعي (١.٢٨٦) عند مستوى دلالة (Sig. = 0.281)، وهي قيمة غير دالة إحصائياً (أكبر من مستوى الدلالة ٠.٠٥)، كما بلغت قيمة (F) لمتغير القلق (١.٩٧٤) عند مستوى دلالة (Sig. = 0.120)، وهي

أيضاً غير دالة إحصائياً (أكبر من مستوى الدلالة ٠.٠٥)، وبالمثل، بلغت قيمة (F) لمتغير الاكتئاب (١.٦٨٨) عند مستوى دلالة (Sig. = 0.172)، وهي غير دالة إحصائياً (أكبر من مستوى الدلالة ٠.٠٥). وبالتالي نستنتج أن متغير العمر ليس له تأثير معنوي على مستويات الدعم الاجتماعي أو القلق أو الاكتئاب لدى أفراد العينة، وبالتالي نرفض فرضية الدراسة التي تنص على أنه يوجد تباين في كل من متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب باختلاف العمر

ثالثاً بالنسبة للوظيفة:

جدول (19) اختبار T لعينتين مستقلتين (Independent Samples T-Test)

لتوضيح التباين في متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب بالنسبة لمتغير الوظيفة.

النوع	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة t	درجات الحرية (df)	مستوى المعنوية (Sig)	مستوى الدلالة
الدعم الاجتماعي	طبي ٤.٢٦٤	٠.٣٢٤٢	٠.٢٦٨	166	٠.٧٨٩	غير دالة إحصائياً
	إداري ٤.٢٥٠	٠.٢٨٠٩				
القلق	طبي ٢.٤٧٢	٠.٢٨٤٠	٠.٢٦٩	166	٠.٧٨٨	غير دالة إحصائياً
	إداري ٢.٤٦٠	٠.٢٨٢١				
الاكتئاب	طبي ١.٧٦٢	٠.٥٢٠٢	٠.٢٣٤	166	٠.٨١٦	غير دالة إحصائياً
	إداري ١.٧٤٤	٠.٤٠٣٤				

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في الوظائف الطبية والإدارية في مستشفى النور في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في القطاعين الطبي والإداري في كل من الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب، حيث جاءت قيم الدلالة (Sig) لكل المتغيرات أكبر من مستوى الدلالة (٠.٠٥)، حيث بلغ متوسط الدعم الاجتماعي لدى العاملين في الوظائف الطبية (٤.٢٦٤) مقابل (٤.٢٥٠) لدى العاملين في الوظائف الإدارية، إلا أن الفروق لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائي (Sig = 0.789)

كما بلغ متوسط القلق لدى العاملين في الوظائف الطبية (٢.٤٧٢) مقابل (٢.٤٦٠) لدى العاملين في الوظائف الإدارية، والفروق كذلك لم تكن معنوية ($Sig = 0.788$) وبالمثل بلغ متوسط الاكتئاب لدى العاملين في الوظائف الطبية (١.٧٦٢) مقابل (١.٧٤٤) لدى العاملين في الوظائف الإدارية، والفروق أيضاً لم تصل إلى مستوى الدلالة ($Sig. = 0.816$). وبالتالي نستنتج أن متغير الوظيفة ليس له تأثير معنوي على مستويات الدعم الاجتماعي أو القلق أو الاكتئاب لدى أفراد العينة، وبالتالي نرفض فرضية الدراسة التي تنص على أنه يوجد تباين في كل من متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب باختلاف الوظيفة.

رابعاً بالنسبة لسنوات الخبرة:

جدول (20) تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لتوضيح التباين في متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة

ANOVA						
مستوى المعنوية Sig.	قيمة (ف) F	متوسط المربعات	درجات الحرية df	مجموع المربعات		
٠.٨٤٨	٠.١٦٦	٠.٠١٦	٢	٠.٠٣٢	بين المجموعات	الدعم الاجتماعي
		٠.٠٩٦	١٦٥	١٥.٨٣٧	داخل المجموعات	
			١٧٦	١٥.٨٣٧	الإجمالي	
٠.٣٨٣	٠.٩٦٧	٠.٠٧٧	٢	٠.١٥٤	بين المجموعات	القلق
		٠.٠٨٠	١٦٥	١٣.١٧٦	داخل المجموعات	
			١٧٦	١٣.٣٣١	الإجمالي	
٠.١٧٤	١.٧٧٠	٠.٤٠٣	٢	٠.٨٠٦	بين المجموعات	الاكتئاب
		٠.٢٢٨	١٦٥	٣٧.٥٥٩	داخل المجموعات	
			١٧٦	٣٨.٣٦٤	الإجمالي	

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في مستشفى النور في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية باختلاف سنوات الخبرة في كل من الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب، حيث جاءت قيم الدلالة (Sig) لكل المتغيرات

أكبر من مستوى الدلالة (٠.٠٠٥)، حيث بلغت قيمة (F) لمتغير الدعم الاجتماعي (٠.١٦٦) عند مستوى دلالة (٠.٨٤٨)

وهي غير دالة إحصائياً (أكبر من مستوى الدلالة ٠.٠٠٥)، كما بلغت قيمة (F) لمتغير القلق (٠.٩٦٧) عند مستوى دلالة (٠.٣٨٣) وهي أيضاً غير دالة إحصائياً (أكبر من مستوى الدلالة ٠.٠٠٥)، وبالمثل بلغت قيمة (F) لمتغير الاكتئاب (١.٧٧٠) عند مستوى دلالة (٠.١٧٤) وهي غير دالة إحصائياً (أكبر من مستوى الدلالة ٠.٠٠٥).

وبالتالي نستنتج أن متغير سنوات الخبرة ليس له تأثير معنوي على مستويات الدعم الاجتماعي أو القلق أو الاكتئاب لدى أفراد العينة، وبالتالي نرفض فرضية الدراسة التي تنص على أنه يوجد تباين في كل من متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب باختلاف سنوات الخبرة.

أهم النتائج التي توصل لها الدراسة:

- بلغ حجم العينة ١٦٨ من العاملين في مستشفى النور بمكة المكرمة من القطاعين الطبي والإداري، وكانت النسبة الأكثر مشاركة في العينة هي الذكور بنسبة ٥٧.١% من إجمالي حجم العينة، وكانت الأعمار الأكثر مشاركة هم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ سنة، وغالبية العينة كانت من القطاع الطبي.

- جاء متوسط الدعم الاجتماعي (٤.٢٥٩) وهو مرتفع، وهذا يدل على أن العاملين يدركون توافر دعم اجتماعي جيد في بيئة العمل، أما بالنسبة للقلق فقد جاء بمتوسط (٢.٤٦٨) وهو يشير إلى أن العاملين لا يعانون بدرجة كبيرة من القلق، وبالنسبة للاكتئاب فقد حصل على متوسط (١.٧٥٦) وهو يعكس متوي جيد من الصحة النفسية لدى العاملين.

- بالنسبة للصدق والثبات نجد أن معاملات ألفا كرونباخ تراوحت بين (٠.٨٤٨ - ٠.٩٤٣)، وهي قيم مرتفعة تدل على ثبات عالي للأداة، وتراوحت معاملات الارتباط تراوحت بين (٠.٤٦٦ - ٠.٧٨٨) عند دلالة (٠.٠٠١)، مما يؤكد صدق الاتساق الداخلي.

- تم قبول الفرض الأول الذي ينص على أنه "توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والقلق لدى العاملين بالمستشفيات"، حيث بلغ معامل الارتباط بين الدعم الاجتماعي والقلق (-٠.٥٢٣) عند مستوى معنوية (٠.٠٠٠) وهذا يشير إلى وجود علاقة سلبية دالة إحصائياً، فزيادة الدعم الاجتماعي ينخفض القلق.
 - تم قبول الفرض الثاني الذي ينص على أنه "توجد علاقة بين الدعم الاجتماعي والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات"، حيث بلغ معامل الارتباط بين الدعم الاجتماعي والقلق (-٠.٤٩٣) عند مستوى معنوية (٠.٠٠٠) وهذا يشير إلى وجود علاقة سلبية دالة إحصائياً، فزيادة الدعم الاجتماعي يقل الاكتئاب.
 - تم رفض الفرض الثالث الذي ينص على أنه "يوجد تباين في متوسطات الدعم الاجتماعي والقلق والاكتئاب تبعاً لمتغيرات (الجنس - العمر - الوظيفة - سنوات الخبرة)"، حيث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لجميع المتغيرات، أي أن هذه العوامل لا تؤثر على مستويات الدعم الاجتماعي أو القلق أو الاكتئاب.
 - يتضح أن الدعم الاجتماعي يلعب دوراً وقائياً مهماً في تقليل مستويات القلق والاكتئاب لدى العاملين بالمستشفيات، بغض النظر عن اختلاف الجنس، أو العمر، أو نوع الوظيفة، أو سنوات الخبرة.
- في ضوء النتائج السابقة، يقدم الباحث التوصيات التالية:**
١. تعزيز برامج الدعم الاجتماعي في بيئة العمل: يجب على إدارة المستشفيات تعزيز أنشطة الدعم الاجتماعي بين العاملين، مثل مجموعات الدعم، والإرشاد المهني، والأنشطة التفاعلية لتعزيز الروابط بين الزملاء.
 ٢. توفير ورش عمل للتعامل مع الضغوط النفسية: تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للعاملين لتعزيز مهارات التكيف مع الضغوط النفسية وتقليل مستويات القلق والاكتئاب.

٣. دمج استراتيجيات الصحة النفسية ضمن سياسات الموارد البشرية: تضمين برامج الصحة النفسية والدعم الاجتماعي كجزء من خطط التطوير المهني والتقييم الدوري للعاملين.

٤. متابعة وتقييم فعالية برامج الدعم الاجتماعي: إجراء تقييم دوري لفعالية البرامج والأنشطة المقدمة لتعزيز الدعم الاجتماعي، مع استخدام نتائج التقييم لتحسين الأداء وزيادة تأثيرها الوقائي على الصحة النفسية للعاملين.

قائمة المراجع:

المراجع العربية:

- أبو أسعد، أحمد وعريبات، أحمد. (٢٠١٥). نظريات الإرشاد النفسي والتربوي (ط.٣)، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
- أحمد الشريفين ومنار بني مصطفى ورامي طشطوش (٢٠١٤). فاعلية خدمات الإرشاد المهني وقلق المستقبل المهني والعلاقة بينهما والعلاقة بينهما لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في الأردن. مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، ٨(٣)، ٤٧٤-٤٩٠.
- إبراهيم، زيزي السيد (٢٠٠٣) تقييم برنامج العلاج المعرفي السلوكي على عينة من المرضى المصابين بالاكتئاب، رسالة دكتوراه، كلية الآداب. جامعة المنيا.
- إبراهيم، عبد الستار. (١٩٩٤). العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث. دار الفجر للنشر والتوزيع، ط ١، القاهرة.
- إبراهيم، عبد الستار. (١٩٩٨). الاكتئاب، اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه، عالم المعرفة، ع ٢٣٩.
- بلان، كمال يوسف. (٢٠١٥). نظريات الإرشاد و العلاج النفسي (ط١). عمان: دار الإعصار العلمي.
- بوقري، مي كامل محمد. (٢٠٠٩). إساءة المعاملة البدنية والإهمال الوالدي والطمأنينة النفسية والاكتئاب لدى عينة من تلميذات المرحلة الابتدائية (١١-١٢) بمدينة مكة المكرمة. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى، السعودي.
- جابر عبد الحميد جابر، علاء الدين كفاقي (١١٩٠): معجم علم النفس والطب النفسي. الجزء (٣)، دار النهضة العربية: القاهرة.
- جريفي سناء. (٢٠٢٣). مساهمة الدعم النفسي الاجتماعي في خفض قلق المستقبل لدى أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، ٣(١٠)، ٢٩٧-٣١٠.
- الحسين، أسماء عبد العزيز (٢٠٠٢). المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعلاج النفسي. ط. ١. دار عالم الكتب، الرياض، السعودية
- حسين، عبد المطيف فرج (٢٠٠٩). الاضطرابات النفسية، الخوف، القلق، التوتر، الانفصام، الأمراض النفسية للأطفال. عمان، الأردن: دار حامد لمنشر والتوزيع.

- دافيدوف، ليندا. (٢٠٠٠). الشخصية- الدافعية- والانفعالات. ترجمة سيد الطواب وحمود عمر. دار ادولية للاستثمارات النقدية.
- رضوان جاب الله شعبان، محمد هريدي محمد. (٢٠٠١). العلاقة بين المساندة الاجتماعية وكل من مظاهر الاكتئاب وتقدير الذات والرضا عن الحياة. مجلة علم النفس. مصر.
- رضوان، سامر جميل. (٢٠٠٣). الصورة السورية لمقياس بيك للاكتئاب (دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق). كلية التربية، قسم الصحة النفسية، جامعة دمشق، دمشق، سورية.
- زعتر، نورالدين. (٢٠٠٩). فعالية برنامج علاج نفسي إسلامي مُقترح في تخفيض القلق (قلق ما قبل العملية الجراحية أنموذجاً) دراسة تجريبية على عينة من لمرضى المقبلين على عملية جراحية بالمؤسسة الإستشفائية العقيد بوقرة بولاية الجلفة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر-بسكرة- كلية الآداب و العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية.
- الزعبي، أحمد محمد عبد المجيد، و كري، لينا. (٢٠١٩). الدعم الاجتماعي المدرك وعلاقته بالاكتئاب: دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة السنة الأولى في جامعة دمشق. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، ٤١(٥)، ٥٨٠-٥٥٣.
- الزغلول، عماد عبد الرحيم. (٢٠١٠). نظريات التعلم(ط١). عمان: دار الشروق.
- زهران، حامد. (١٩٩٧). الصحة النفسية والعلاج النفسي. ط (٣)، القاهرة، عالم الكتب.
- سرحان، وليد والتكريتي، عدنان وحباشنة، محمد. (٢٠٠٨). القلق. دار المجدلوي للنشر والتوزيع. ط ٢، عمان، الأردن.
- الشاذلي، عبد الحميد (٢٠٠٠). الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية. المكتبة الجامعية الإسكندرية. ط ٢، الإسكندرية، مصر.
- الشناوي محمد محروس، ومحمد السيد عبد رحمن. (١٩٩٤). المساندة الاجتماعية والصحة النفسية، مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر.
- الشناوي، محمد محروس. (٢٠٠٠). نظريات الإرشاد والعالج النفسي. دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر.

- طه، منى حسنين (٢٠٢١). دور البراعة التنظيمية كمتغير وسيط في العلاقة بين القيادة الملهمة و التماثل التنظيمي: دراسة تطبيقية. المجلة العلمية للدراسات و البحوث المالية و الإدارية، ١٠، (١)، ١٠٩-١٥٠.
- عبد الحميد محمد شاذلي، (٢٠٠١)، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية المكتبة الجامعية أسوان، (٦٢-٦٧).
- عبد الرحيم، ولاء رجب (٢٠١٦). الضغوط النفسية للمتفوقين وكيفية مواجهتها. دار العلوم للنشر والتوزيع.
- عبد المسيح، خلف. (٢٠٠١). دليل الصحة النفسية للأطباء والعاملين في الرعاية الصحية الأولية. منظمة الصحة العالمية، دمشق.
- عثمان، فاروق السيد. (٢٠٠١). القلق وإدارة الضغوط النفسية. القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.
- عثمان، محفوظ. (٢٠٠٠). يوم دراسي بعنوان الصدمة النفسية وآثارها، كلية التربية، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين.
- عكاشة، أحمد (٢٠١٥). الطب النفسي المعاصر. مكتبة أنجلو المصرية. ط ١٧، القاهرة.
- عكاشة، محمود. (٢٠٠٣). مدخل الى علم النفس الاجتماعي. المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر.
- علي، عبد السلام. (٢٠٠٥). المساندة الاجتماعية وتطبيقاتها العملية في حياتنا اليومية، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- غانم أمين، كافي هديل. (٢٠٢٤). أنماط الشخصية وعلاقتها بالاكنتاب لدى العاملين بالمصالح الاستعجالية (أطباء، مرضين)، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم علم النفس وعلوم التربية.
- غريب، غريب عبدالفتاح (٢٠٠٢) التأخر التحصيلي والأعراض الاكتئابية لدى تلاميذ مرحلة المراهقة المبكرة، المؤتمر السنوي التاسع، مركز الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس، القاهرة، ص. ٧٣٣-٧٦٧.
- غزالي، عبد القادر. (٢٠١٦). قلق المستقبل وعلاقته بصورة الجسم لدى طالبات معهد التربية البدنية والرياضية، الأكاديمية الاجتماعية و الإنسانية ج، /قسم العلوم الاجتماعية.

- قنون خمسية. (٢٠٠٧). الدعم الاجتماعي المدرك وعلاقته بالاكنتاب لدى المصابين بالأمراض الانتانية، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير.
- كفاي، علاء الدين. (١٩٩٠). الصحة النفسية. هجر للطباعة والنشر، قطر.
- كيال. دحام. (١٩٩٠). علاقة القلق بالترتيب الذهني. دارلا الكتاب للنشر والطباعة والتوزيع، ط ١، القاهرة.
- المصري محمد بن مكرم علي. (١٩٥٥). لسان العرب، الجزء ٥-٦ دار الصادر بيروت.
- محمد حامد ابراهيم الهنداوي. (٢٠١١). الدعم الاجتماعي وعلاقته بمستوى الرضا عن جودة الحياة لدى المعاقين حركيا بغزة. رسالة مكملة لنيل درجة ماجستير في علم النفس.
- محمد خديجة بدر الدين أحمد محمد. (٢٠٢٢). فاعلية برنامج لتنمية مهارات الدعم النفسي الاجتماعي الأولي خلال الأزمات وخفض مستوى قلق المستقبل في ظل جائحة كورونا لدى أمهات أطفال الروضة، ٢٢(٢)، ٣١١-٣٨٤.
- محمد عبد الله عباس عكاشة. (٢٠٢١). القلق وعلاقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى معلمات مرحلة الطفولة المبكرة، جامعة بني سويف - كلية التربية للطفولة المبكرة، مجلة دراسات الطفولة، ٣(٥)، ٥٩٥-٦٣٢.
- المدني، عادل اسماعيل، علي. (٢٠١٠). الطب النفسي، مطبعة الرحمة، القاهرة
- مرسى ابراهيم كمال. (٢٠٠٠). السعادة وتنمية الصحة النفسية. ط ١، دار النشر للجامعات.
- المسحر، ماجد أحمد حسن. (٢٠٠٧). إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة كما تدركها طالبات الجامعة وعلاقتها بأعراض الاكنتاب. رسالة ماجستير. جامعة الملك سعود، السعودية.
- المعايطه، عبد العزيز. (٢٠٠٢). المدخل إلى علم النفس. دار الثقافة ودار العلمية الدولية ط ١، عمان.
- المطيري، معصومة سهيل. (٢٠٠٥). الصحة النفسية، مفهوما، واضطراباتهما. مكتبة الفالح لنشر والتوزيع.
- الميلادي، عبد المنعم (٢٠٠٤). الأمراض والاضطرابات النفسية. مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر.
- يخلف عثمان. (٢٠٠١). علم نفس الصحة الأسس النفسية والسلوكية للصحة، الطبعة الأولى، دار الثقافة
- للطباعة والنشر.

- يوسف، أحمد حسين. (٢٠٢٤). تأثير الدعم الاجتماعي في مكان العمل على الأداء الوظيفي: الدور الوسيط للتمائل التنظيمي- دراسة ميدانية بالتطبيق على العاملين بجامعة بني سويف. مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية، ٦١(٦)، ٢٥٧-٣١٠.

References:

- Abdel E, Salwa, A. (2021), Sources of anxiety and tension in university students – A case study for Egypt. The 19th International Conference, Istanbul, Yurki, 10(17), 369-379.
- Agarwal, Manisha & Sharma, Abhishek. (2011). Effects of Hospital Workplace Factors on the Psychological Well-being and Job Satisfaction of Health Care Employees. Journal of Health Management, 13(4), 439-461.
- Ahlstedt, C., Moberg, L., Brulin, E., & Nyberg, A. (2024). Social support from manager and co-workers in relation to registered nurses' work motivation in three healthcare settings: A cross-sectional study of a Swedish national sample. Journal of nursing scholarship, 2(3), 1-12.
- Alalawi, M., Makhlof, M., Hassanain, O., Abdelgawad, A., Nagy, M. (2023). Healthcare workers' mental health and perception towards vaccination during COVID-19 pandemic in a Pediatric Cancer Hospital. Scientific Reports, 13(2), 329-310.
- Alnazly E, Khraisat OM, Al-Bashaireh AM, Bryant CL (2021) Anxiety, depression, stress, fear and social support during COVID-19 pandemic among Jordanian healthcare workers. PLoS ONE 16(3), 247-256.
- Alkabaa, A. S., Taylan, O., Alqabbaa, H. S., & Guloglu, B. (2025). Assessing occupational work-related stress and anxiety of healthcare staff during COVID-19 using fuzzy natural language-based association rule mining. Healthcare, 13(14), 1745-1756.
- Alsubaie, Mohammed & Stain, Helen & Webster, Lisa & Wadman, Ruth. (2019). The role of sources of social support on depression and quality of life for university students. International Journal of Adolescence and Youth. 24(4), 1-13.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- DSM5. American Psychiatric Association.
- Armstrong, A. (2011). What can psychoanalysis tell us about depression. Student psychology journal, 1(1), 113-122.
- Arnetz, B.B. (2001). Psychosocial challenges facing physicians of today. Social Science & Medicine, 5(2), 203-13.

- Avr, Madhavi & Srinivasa Bandaru, Rao. (2024).A study of work stress and its impact on employees' performance and job satisfaction.International Journal of Education and Science Research Review,10(4),119-125.
- Blizzard, Heather M.(2020).Social Support Among Undergraduate Students. Measure Development and Validation,Electronic Theses and Dissertations. 1727.
- Buunk, B., &Hoorens, v. (1992): social support and stress: the role of social comparison and social exchange processes. British journal of clinical psychology.
- Cutrona, C. & Russell. (1990): Type of social support and specific stress: Towards a theory of optimal matching, in: B.R.Sarason, et al (eds.) social support: An Interact ional view, New York, Wiley, 26-40.
- Dvorak , S.M. (1988). Lone Liness and social support .the Relationship Between two Multid Mensional Contructs ,Dissertation Abstracts International Voi ,40
- Emmons, R. A. & Colby, P. M. (1995). Emotional conflict and well-being relation to perceived availability, daily utilization, and observer reports of social support. Journal of Personality and Social Psychology, 68(1), 947–959.
- Ersoy, M., Akçaoğlu, M.Ö.(2025).The interplay between social support, acculturative stress, perceived stress and generalized anxiety among international students. Curr Psychol ,2(1),1-12.
- Fernandes, I. M. D. C., Ribeiro, A. M., Gomes, R. L., Lopes, J. S. S., Vanderlei, L. C. M., & Lorençoni, R. M. R. (2019). Anxiety, depression and stress among employees of a public higher education institution in São Paulo, Brazil. Revista brasileira de medicina do trabalho : publicacao oficial da Associacao Nacional de Medicina do Trabalho-ANAMT, 17(4), 530–536.
- Hyewon, Lim, et al (2024), Stigma and quality of life in lung cancer patients: The mediating effect of distress and the moderated mediating effect of social support, Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing,11(1),30-37.
- Jolly, Phillip & Kong, Dejun Tony & Kim, Kyoung Yong. (2020). Social support at work: An integrative review. Journal of Organizational Behavior. 42(2),229-251.
- Jo, M., Shin, H., Kabbe, A., & Kim, S. J. (2024). Depressive symptoms and quality of life among women experiencing infertility: The moderating effect of perceived social support. Heliyon, 11(1),10-21.
- Katsiroumpa, A., Moisoglou, I., Papathanasiou, I. V., Malliarou, M., Sarafis, P., Gallos, P., Konstantakopoulou, O., Rizos, F., & Galanis, P. (2025). Resilience and Social Support Protect Nurses from Anxiety and Depressive Symptoms: Evidence from a Cross-Sectional Study in the Post-COVID-19 Era. Healthcare (Basel, Switzerland), 13(6), 582-598.

- Lawlor, Clark (2012). From Melancholia to Prozac: A History of Depression. Oxford University Press, New York, USA
- Lerner, D., Adler, D. A., Rogers, W. H., Chang, H., Lapitsky, L., McLaughlin, T., & Reed, J. (2010). Work performance of employees with depression: the impact of work stressors. American journal of health promotion : AJHP, 24(3), 205–213.
- Li, G., Li, Y., Lam, A. I. F., Tang, W., Seedat, S., Barbui, C., Papola, D., Panter-Brick, C., Waerden, J. V., Bryant, R., Mittendorfer-Rutz, E., Gémes, K., Purba, F. D., Setyowibowo, H., Pinucci, I., Palantza, C., Acarturk, C., Kurt, G., Tarsitani, L., Morina, N., ... Hall, B. J. (2023). Understanding the protective effect of social support on depression symptomatology from a longitudinal network perspective. BMJ mental health, 26(1),30-39.
- Li, J., Theng, Y. L., & Foo, S. (2015). Does psychological resilience mediate the impact of social support on geriatric depression? An exploratory study among Chinese older adults in Singapore. Asian journal of psychiatry, 14(1), 22–27.
- Olaleye, B.& Lekunze, J. (2024). Emotional Intelligence and Psychological Resilience on Workplace Bullying and Employee Performance: A Moderated-Mediation Perspective. Journal of Law and Sustainable Development, 12(1),1-25.
- Omichi, C., Kaminishi, Y., Kadotani, H., Sumi, Y., Ubara, A., Nishikawa, K., Matsuda, A., & Ozeki, Y. (2022). Limited social support is associated with depression, anxiety, and insomnia in a Japanese working population. Frontiers in public health, 10(1),88-95.
- Peter, P. J., de Mola, C. L., de Matos, M. B., Coelho, F. M., Pinheiro, K. A., da Silva, R. A., Castelli, R. D., Pinheiro, R. T., & Quevedo, L. A. (2017). Association between perceived social support and anxiety in pregnant adolescents. Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil), 39(1), 21–27.
- Rachman, S. (1988). Panics and their consequences: A review and prospect. In S. Rachman & J. D. Maser (Eds.), Panic: Psychological perspectives ,259–303, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Rehm ,L. (2015). Cognitive and behavioral theories of depression. New York: John wiley & sons ,inc.
- Sarason, Irwin & Levine, Henry & Basham, Robert & Sarason, Barbara. (1983). Assessing social support: The Social Support Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology,44(1),127-139.
- Sharp, W.G., Sherman, C., & Gross, A.M. (2007). Selective mutism and anxiety: a review of the current conceptualization of the disorder. Journal of anxiety disorders, 21(4), 560-568.
- Wang F and Qu J-G (2022) A study of relationship between social support, work values and job search behavior. Front. Psychol. 13(1),102-110.

- Yang, L., Wang, N., Li, D., Xuesen, Z., Mofeial, W., Yichi, Z., Tang, L. (2025). Social support and anxiety, a moderated mediating model. *Sci Rep* 15(1), 293-302.
- Yu, X., Xiong, F., Zhang, H., Ren, Z., Liu, L., Zhang, L., & Zhou, Z. (2023). The Effect of Social Support on Depression among Economically Disadvantaged College Students: The Mediating Role of Psychological Resilience and the Moderating Role of Geography. *International journal of environmental research and public health*, 20(4), 30-39.
- Zaleski, Z. (1996). Future Anxiety: Concept measurement and preliminary person individual difference, 21(2), 1-11.
- Zimet, G. D., et al (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. *Journal of Personality Assessment*, 52(1), 2-15.
- Zhang, J., Zhao, S., Lester, D., & Zhou, C. (2014). Life satisfaction and its correlates among college students in China: A test of social reference theory, *Asian Journal of Psychiatry*, 10(1), 17-20.
- Zhang, L., He, N. (2025). Current status and effectiveness of social support at alleviating trait anxiety in Chinese college students. *Curr Psychol*, 2(1), 40-48.
- Zhang, L., Ni, Z., Liu, Y., & Chen, H. (2023). The effectiveness of e-health on reducing stigma, improving social support and quality of life among people living with HIV: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *International journal of nursing studies*, 148(2), 1-10

Social support and its relationship to some psychological disorders among hospital workers.

Abstract:

The aim of this study was to examine social support and its relationship with certain psychological disorders among hospital staff. The study sample consisted of 168 employees at Al-Noor Hospital in Makkah, including both medical and administrative staff. Males constituted the majority (57.1%), and most participants were under 30 years old, with medical staff representing the largest group.

Results showed a correlation analysis revealed a significant negative relationship between social support and anxiety (-0.523) and between social support and depression (-0.493), indicating that higher social support is associated with lower anxiety and depression. Demographic variables (gender, age, job type, years of experience) showed no significant effect on social support, anxiety, or depression.

The study concluded that social support plays a protective role in reducing anxiety and depression among hospital staff, and recommended strengthening workplace social support programs, training workshops for coping skills, integrating mental health into HR policies, and continuous evaluation of program effectiveness.

Keywords: Social Support, Anxiety, Depression, Hospital Staff, Psychological Disorders.